



สวทช
NSTDA



แนวทางการวิเคราะห์ และออกแบบการดูแลทางสังคม

สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง

จากการใช้งาน Platform Social Telecare

เยาวเรศ คำมะนาว ฤทธิสัทธี เจนะ และ รัชพิพรรณ คำหอม



โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพ
และสังคมผ่าน SOCIAL TELECARE PLATFORM

กรกฎาคม 2568

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง จากการใช้งาน PLATFORM SOCIAL TELECARE

ผู้แต่ง ศศ.ร.เยาวเรศ คำมะนาด
 ศศ.ร.ระพีพรรณ คำหอม
 ศศ.ร.ฤทธิสกี เจนะนะ
ISBN : 978-616-94737-1-8
พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2568
จำนวน 500 เล่ม

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ NATIONAL LIBRARY OF THAILAND CATALOGING IN PUBLICATION DATA

เยาวเรศ คำมะนาด.

“แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง” จากการ
ใช้งาน PLATFORM SOCIAL TELECARE.--กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์, 2568.
80 หน้า.

1. บริการทางการแพทย์. 2. บริการสังคม. I. ระพีพรรณ คำหอม, ผู้ร่วมแต่ง. II. ฤทธิสกี เจ
นะ, ผู้ร่วมแต่ง. III. ชื่อเรื่อง.

362.1

ISBN 978-616-94737-1-8

จัดทำโดย โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพและ
สังคมผ่าน SOCIAL TELECARE PLATFORM

เจ้าของ/ลิขสิทธิ์ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เลขที่ 255 ตึกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 050 9427, 098 380 1351 (สำนักงาน)
EMAIL: THAISOCIALWORKCOUNCIL@GMAIL.COM

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์ที่ บริษัท จรัสสินทวงศ์การพิมพ์ จำกัด โทรศัพท์ 02-809-22813
WWW.FASTBOOKTHAI.COM
E-MAIL : FASTBOOKTHAI@GMAIL.COM

“

**นวัตกรรมที่แท้จริง
ไม่ได้วัดจากความซับซ้อนของมัน
แต่วัดจากผลกระทบที่มีต่อชีวิตผู้คน**

**TRUE INNOVATION IS NOT MEASURED BY ITS COMPLEXITY,
BUT BY THE IMPACT IT HAS ON PEOPLE'S LIVES.**

”

คำนำ

หนังสือ “**แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางจากการใช้งาน PLATFORM SOCIAL TELECARE**” เล่มนี้ ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมืออันทรงคุณค่าระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาโดยมีจุดเริ่มต้นจาก “โครงการการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างเสริมระบบบริการสุขภาพและสังคมผ่าน SOCIAL TELECARE PLATFORM” ซึ่งได้พัฒนา PLATFORM SOCIAL TELECARE (PST) ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนัก 7 (สสส.) ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นำโดยศาสตราจารย์ ศด.ระพีพรรณ คำหอม นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และอาจารย์วัชร อมศิริ อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็น “วิศวกรเพื่อประชาชน” เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ด้านปัญญาประดิษฐ์และสารสนเทศ ผู้ออกแบบ PLATFORM SOCIAL TELECARE รวบรวมเครื่องมือวิเคราะห์และวินิจฉัยทางสังคม จำนวน 39 เครื่องมือ ที่นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และเครือข่าย สหวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการให้บริการกับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายการเข้าถึงบริการการดูแลทางสังคมได้อย่างทั่วถึง

ความท้าทายของระบบสุขภาพสมัยใหม่ ในการใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (TELEMEDICINE) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยในชุมชนที่ห่างไกล ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและการเดินทาง สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวมต่อเนื่อง ครบถ้วน ผ่านระบบและกลไกบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้ง ลดข้อจำกัดการบริหารอัตราค่าส่งนักสังคมสงเคราะห์ที่มีจำกัด แต่เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ได้รับการดูแลสิทธิและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ความจำเป็นในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีแนวทางและเครื่องมือในการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ PST อย่างเต็มที่

ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนัก 7 (สสส.) สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุกท่าน นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และทีมสุขภาพในโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการใช้งาน PLATFORM SOCIAL TELECARE มา ณ โอกาสนี้

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1. นิยามศัพท์	2
2. นิยามเชิงปฏิบัติการ	3
3. ความสำคัญของปัญหาทางานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	6
4. แนวโน้มและโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	7
บทที่ 2 โครงสร้างระบบ PLATFORM SOCIAL TELECARE	8
1. โครงสร้างระบบ PLATFORM SOCIAL TELECARE	8
2. ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง (ระบบประเมินและเมนูพื้นฐานต่างๆ)	10
3. โครงสร้างระบบกิจกรรมทางสังคม PLATFORM SOCIAL TELECARE	16
บทที่ 3 การวินิจฉัย เครื่องมือและบริการทางสังคมผ่าน PLATFORM SOCIAL TELECARE	17
1. การวินิจฉัยทางสังคมใน PLATFORM SOCIAL TELECARE	17
2. แนวทางการวินิจฉัยทางสังคมใน PLATFORM SOCIAL TELECARE	21
3. ตัวอย่างแนวทางในบันทึกสหกลุ่มเปราะบางใน PLATFORM SOCIAL TELECARE	27
4. ตัวอย่างแนวทางการออกแบบบริการและบันทึกสหในสหกลุ่มเปราะบางที่พบบ่อย	30
5. รายละเอียดและวิธีการ (PROCESS) การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วย	36
บทที่ 4 แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผ่าน PLATFORM SOCIAL TELECARE	39
1. ความหมายของแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม	39
2. องค์ประกอบหลัก	39
3. วิธีการที่ประเมินสามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม	39
4. การตรวจประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	40
5. การประเมินปัญหาทางสังคมและความพร้อมของผู้ป่วย ครอบครัว ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	42
6. ประเมินจิตสังคม ประเมินความพิการ ความบกพร่อง ความสามารถทางสังคม ทักษะทางสังคม	43
7. การจัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม และฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	44
8. การเยี่ยมบ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	46
9. การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต และติดตามประเมินปัญหาทางสังคมป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำและการฟื้นฟูสภาพ (RECOVERY) ผู้ป่วยหลังจำหน่าย	47
10. การประสานงานและส่งต่อ (COORDINATION & REFERRAL)	51
ข้อสรุป	54
ภาคผนวก	
บรรณานุกรม	

“สุขภาพ” ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2001) มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการ หากแต่ หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม การดูแลผู้ป่วยในระบบบริการสุขภาพยุคใหม่ จึงต้องก้าวข้ามขอบเขตของการรักษาทางการแพทย์แบบแยกส่วน และหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลแบบองค์รวม ที่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่ขาดหลักประกันสุขภาพ

ในบริบทเช่นนี้ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จึงมีบทบาทที่สำคัญ ในการเติมเต็มช่องว่างของระบบสุขภาพ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินความต้องการเฉพาะบุคคล ให้การสนับสนุนด้านสิทธิสวัสดิการ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การทำงานกับครอบครัวและชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงทรัพยากรทางสังคม ให้เข้าถึงผู้ป่วยอย่างเท่าเทียม บทบาทเหล่านี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุว่านักสังคมสงเคราะห์เป็นวิชาชีพ ที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง ในการส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่า

อย่างไรก็ตามในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลและการจัดการบริการแบบบูรณาการ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ก็ต้องมีการปรับตัวควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เช่น SOCIAL TELECARE PLATFORM และ APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการ จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

ระบบ SOCIAL TELECARE เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการประเมิน วินิจฉัยและติดตามผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง โดยใช้เครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์อย่างเป็นระบบ นักสังคมสงเคราะห์สามารถใช้ระบบนี้ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง บันทึกผลการประเมิน รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล (เช่น HOSXP) ผ่าน API เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประชากร สิทธิการรักษา รายได้ อาชีพ หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ ปัญหาทางสังคมและครอบครัวได้ทันที การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้การทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลมีความเป็นระบบมากขึ้น โดยยึดหลักฐานเชิงประจักษ์ (EVIDENCE-BASED PRACTICE) ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทาง ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ควบคู่กับศิลปะแห่งความเข้าใจมนุษย์ เช่น การสื่อสารเชิงสัมพันธ์และการเข้าถึงบริบทชีวิตผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง การประสานระหว่างศาสตร์ ศิลปะและเทคโนโลยี ในกระบวนการทำงาน ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดภาระงานซ้ำซ้อน เร่งรัด การวางแผนดูแลรายบุคคล และลดข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ชัดเจน ได้แก่ การใช้ API เพื่อดึงข้อมูลการประเมินภาวะซึมเศร้า การประเมินความพร้อมของครอบครัว หรือการประเมินสถานการณ์ปัญหาสังคมเฉพาะรายเข้าสู่ระบบแผนการดูแลรายบุคคล (INDIVIDUAL CARE PLAN) ทำให้การดำเนินการของนักสังคมสงเคราะห์ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถประสาน งานร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างสอดคล้อง ระบบ SOCIAL TELECARE ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการรายกรณี (CASE MANAGEMENT) และการวางแผนการดูแลร่วมกับครอบครัว โดยอิงตามหลักฐาน (EVIDENCE-BASED) ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของการส่งเสริมการดูแลเฉพาะรายที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและครอบครัวในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ดังนั้นการออกแบบบริการทางสังคมสงเคราะห์ในระบบสุขภาพ จึงจำเป็นต้องอาศัย ทั้งมุมมองเชิงวิชาชีพและศักยภาพทางเทคโนโลยี ควบคู่กัน โดยเฉพาะในบริบทของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ผู้ป่วยต้องการการดูแลต่อเนื่อง และการสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จึงต้องไม่เพียงมีทักษะในการประเมินปัญหาทางสังคมและความเปราะบางของผู้ป่วย แต่ยังต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิทัล การสื่อสารผ่านระบบทางไกล และการบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศสุขภาพ (HEALTH INFORMATION SYSTEMS) เพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเข้าถึงได้อย่างแท้จริงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีกลยุทธ์ยังสามารถช่วยสนับสนุนในมิติอื่นๆ ได้แก่ การจัดการเครือข่ายบริการในชุมชน (COMMUNITY RESOURCE MAPPING) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามแนวโน้มปัญหาทางสังคมในพื้นที่การพัฒนา DASHBOARD สำหรับผู้บริหารและนักสังคมสงเคราะห์การขยายระบบติดตามและป้องกันปัญหาในระยะยาว

การออกแบบระบบดูแลแบบองค์รวมที่บูรณาการระหว่าง “เทคโนโลยี” และ “จริยธรรมวิชาชีพ” จะนำไปสู่ระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยในทุกช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน

1. นิยามศัพท์

การออกแบบบริการ หมายถึง การออกแบบบริการรายบุคคล ในงานบริการทางสังคม เพื่อกลุ่มเปราะบางโรงพยาบาลเป็นกระบวนการวางแผนการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นตัวบุคคลเป็นศูนย์กลาง โดยออกแบบแนวทางและกิจกรรมการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ บริบท ศักยภาพ และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแต่ละราย แทนที่จะใช้รูปแบบการช่วยเหลือสำเร็จรูปหัวใจสำคัญของการออกแบบบริการรายบุคคลคือการยอมรับว่าผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง (เช่น ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยยากไร้ เด็กที่ถูกกระทำรุนแรง ผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเวช ฯลฯ) มีมิติของปัญหาที่ซับซ้อนและไม่เหมือนกัน

กระบวนการดูแลผู้ป่วย หมายถึง “กระบวนการดูแลผู้ป่วย” ตามขั้นตอนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ในการจัดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละบุคคลและครอบครัว โดยมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนหลัก ตาม “กระบวนการดูแลผู้ป่วย” (PROCESS OF PATIENT CARE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5” (HOSPITAL AND HEALTHCARE STANDARDS, VERSION 5) PMQA MODEL นำมาประยุกต์แนวทางการออกแบบบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ดังนี้

- 1) การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (III - 1) : จุดเริ่มต้นที่ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการ เช่น การจัดบริการ การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ เป็นประตูแรกสู่การดูแล
- 2) การประเมินผู้ป่วย (III - 2) : การรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจผู้ป่วยอย่างรอบด้าน เช่น การประเมินผู้ป่วย การส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัย และการวินิจฉัย เพื่อวางแผนการดูแล
- 3) การวางแผน (III - 3) : การกำหนดแนวทางการดูแลที่ชัดเจน เช่น การวางแผนดูแลผู้ป่วยและการวางแผนจำหน่าย เพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีทิศทาง
- 4) การดูแลผู้ป่วย (III - 4) : การดำเนินการตามแผนการดูแลที่วางไว้ เช่น การดูแลทั่วไป การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการความเสี่ยงสูง และการดูแลเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
- 5) การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว (III - 5) : การสื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดูแลตนเอง เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอน
- 6) การดูแลต่อเนื่อง (III - 6) : การติดตามและดูแลผู้ป่วยหลังจากจำหน่าย เช่น การจำหน่ายติดตามและดูแลตามนัด การส่งต่อผู้ป่วย และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยยังคงได้รับการดูแลที่ดี แม้จะออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว

หัวใจสำคัญของการประยุกต์ใช้สำหรับนักสังคมสงเคราะห์แพทย์ คือ “การสื่อสารและการเสริมพลัง” (III-5) นักสังคมสงเคราะห์แพทย์ต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ป่วย ครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดูแลสุขภาพของตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ระบบการแพทย์ทางไกล (TELEMEDICINE) หมายถึง เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพร่วมกับปัญหาสังคม เพื่อให้คำปรึกษา การวินิจฉัยโรค หรือการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจากระยะไกล

PLATFORM SOCIAL TELECARE หมายถึง เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบการให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือประเมินทางสังคม การออกแบบบริการสุขภาพและสังคมดิจิทัล และการรับส่งข้อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวินิจฉัยปัญหาสังคม เพื่อให้คำปรึกษา การวินิจฉัยโรค หรือการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจากระยะไกล

ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDSS) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่ต้องรักษาระยะยาว การรักษาเป็นเพียงการพยายงไม่ให้เกิดการสูญเสียการทำงานของร่างกายมากขึ้น มีปัญหาสุขภาพพร้อมกับปัญหาสังคม ป่วยจากสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยต้องการการดูแลทางสุขภาพพร้อมกับทางสังคมร่วมกัน ต้องการการสนับสนุน การปกป้องเพราะปัจจัยทางด้านอายุ ความพิการ ความเสี่ยงต่อการถูกรังแก หรือถูกเพิกเฉย

ระบบการดูแลทางสังคม (SOCIAL CARE SYSTEM) หมายถึง ระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือปกป้อง ค้ำครอง พิทักษ์สิทธิ เสริมพลัง ให้ความรู้สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติการการดูแลทางสังคม ในระบบแพทย์ทางไกลที่สนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการดูแลทางสังคมในคลินิกสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล

นักสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต หมายถึง นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และได้รับใบประกอบวิชาชีพรับอนุญาตถูกต้องตามพรบ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

2. นิยามเชิงปฏิบัติการ

กระบวนการดูแลผู้ป่วยในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ หมายถึง กระบวนการดูแลผู้ป่วยตามขั้นตอนมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่องในการจัดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ทั้งนี้มีการนำกระบวนการ วิธีการทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ ดังนี้

ลำดับ	กระบวนการดูแลผู้ป่วย	สาระสำคัญในบริบทการดูแลผู้ป่วย	การประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
1	III - 1: การเข้าถึงและเข้ารับบริการ	เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการ และได้รับการจัดบริการที่เหมาะสม	การคัดกรองปัญหาทางสังคมเบื้องต้น :
			>นักสังคมสงเคราะห์แพทย์คัดกรองผู้ป่วยทุกคนหรือกลุ่มเสี่ยง (เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ) ทันทีที่เข้าสู่โรงพยาบาล
			>ใช้แบบฟอร์มคัดกรองหรือสัมภาษณ์สั้นๆ เพื่อระบุปัญหาเร่งด่วน เช่น ไม่มีญาติ, ยาจน, ไม่มีที่พักพิง, ความรุนแรงในครอบครัว
2	III - 2: การประเมินผู้ป่วย	การรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอย่างรอบด้าน	การประเมินปัญหาทางสังคมอย่างลึกซึ้ง
			> สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อทำความเข้าใจสภาพปัญหาทางสังคม, เศรษฐกิจ, จิตใจ, อารมณ์, ความสัมพันธ์ในครอบครัว และระบบสนับสนุนทางสังคม
			>วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วย การรักษา และคุณภาพชีวิต
3	III - 3: การวางแผน	การกำหนดแนวทางการดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยให้เหมาะสมกับปัญหาและเป้าหมายที่ตั้งไว้	> ประสานข้อมูลกับทีมแพทย์เพื่อประเมินความเชื่อมโยงของปัญหาสุขภาพกับปัญหาทางสังคม
			การวางแผนการช่วยเหลือทางสังคมแบบองค์รวม > ร่วมกับผู้ป่วย, ครอบครัว, และทีมสหสาขาวิชาชีพ (แพทย์, พยาบาล) กำหนดแผนการช่วยเหลือทางสังคมที่เป็นรูปธรรม >ระบุเป้าหมายการช่วยเหลือ (เช่น การจัดหาผู้ดูแล, การขอทุนสนับสนุน, การฟื้นฟูสภาพจิตใจ)
			>วางแผนการประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก หรือองค์กรชุมชน

ลำดับ	กระบวนการดูแลผู้ป่วย	สาระสำคัญในบริบทการดูแลผู้ป่วย	การประยุกต์ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
4	III - 4: การดูแลผู้ป่วย	การดำเนินการตามแผนการดูแลที่วางไว้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและบริการตามแนวทางที่กำหนด	การดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานทางสังคม : เช่น > ให้คำปรึกษาทางสังคมรายบุคคล/กลุ่ม แก่ผู้ป่วยและครอบครัว การจัดการทรัพยากรและการพิทักษ์สิทธิ์ การจัดการรายกรณี ประสานงานกับแหล่งทุน, มูลนิธิ, หรือหน่วยงานสวัสดิการ เพื่อขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน, อุปกรณ์, หรือบริการที่จำเป็นอื่น ๆ
			> ดำเนินการจัดหาผู้ดูแล หรือประสานงานการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
			> ให้ความรู้และทักษะในการเผชิญปัญหาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
5	III - 5: การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว	การสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นและสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและดูแลตนเอง	การเสริมพลังและสร้างความรู้ความเข้าใจ:
			> ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย, สวัสดิการ, และแหล่งทรัพยากรต่างๆ อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย
			> ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาและการ
6	III - 6: การดูแลต่อเนื่อง	การติดตามผลลัพธ์การดูแลและการเตรียมความพร้อมก่อนการจำหน่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล	> ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวเข้าใจสถานการณ์ของตนเอง และพัฒนาศักยภาพในการจัดการปัญหา
			การเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายและการดูแลติดตามผล :
			>- ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัวในการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้าน วางแผนการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่าย เช่น การประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานดูแลระยะยาว หรือหน่วยบริการในชุมชน
			>- ติดตามผลการช่วยเหลือทางสังคม และให้คำปรึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็น
			>- จัดทำระบบส่งต่อและรับการดูแลต่อเนื่องให้เป็นไปอย่างราบ

การประเมินระดับความรุนแรง หมายถึงการประเมินความรุนแรงของแต่ละปัญหาจะใช้ระดับคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 4 พร้อมกับรหัสเพิ่มเติม 8 (ไม่ระบุ) และ 9 (ไม่เกี่ยวข้อง) โดยมีความหมายดังนี้

ระดับ	ความหมาย	นิยาม
0 (กลุ่มสีเขียว)	“ไม่มีความยากลำบาก/ปัญหา”	บุคคลไม่มีปัญหาดังกล่าวหรือปัญหาเกิดขึ้นน้อยมาก (ประมาณ 0–4% ของเวลา)
1 (กลุ่มสีเหลือง)	“มีความยากลำบาก/ปัญหา เล็กน้อย”	ปัญหานั้นเกิดขึ้นไม่บ่อย (ประมาณ 5–24% ของเวลา) โดยบุคคลสามารถรับมือได้ และไม่รบกวนกิจวัตรประจำวันมากนัก

ระดับ	ความหมาย	นิยาม
ระดับ 2 (กลุ่มสีเหลือง)	“มีความยากลำบาก/ ปัญหา ปานกลาง”	ปัญหานั้นมีความรุนแรงในระดับที่เกิดขึ้นในช่วง 25–49% ของเวลา และอาจเริ่มมีผลกระทบต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ระดับ 3 (กลุ่มสีแดง)	“มีความยากลำบาก/ ปัญหา รุนแรง”	ปัญหานั้นเกิดขึ้นมากกว่า 50% ของเวลา (50–95%) ทำให้บางกิจกรรมหรือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
ระดับ 4 (กลุ่มสีแดง)	“มีความยากลำบาก/ ปัญหา ที่สุดหรือทั้งหมด”	ปัญหานั้นเกิดขึ้นแทบทุกวัน (96–100%) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้าน
ระดับ 8 (ไม่ระบุ)		ใช้เมื่อมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุความรุนแรงของปัญหานั้นได้
ระดับ 9 (ไม่เกี่ยวข้อง)		ใช้ในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะใช้รหัสเฉพาะตามที่กำหนดไว้

ระบบ AMED HOME WARD หมายถึง ระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน เป็นแพลตฟอร์มที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแบบและพัฒนาระบบตั้งแต่ เมษายน 2563 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ในระยะแรก โดยมี เป้าหมายเพื่อใช้บริหารจัดการดูแลผู้ป่วยในสถานกักตัวผู้ป่วยโรคโควิด-19 เช่น โรงพยาบาลสนาม HOSPITALS HOME/COMMUNITY ISOLATION อย่างเป็นระบบ รองรับการทำงานของแพทย์และพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดเด่นในการสื่อสารและการบันทึกข้อมูลผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO CALL) พร้อมระบบรายงานข้อมูลสัญญาณชีพทางไกล (TELE-VITAL SIGN MONITOR) เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด ความดันโลหิต อาการที่สำคัญ บริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน A-MED HOME WARD) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเปราะบางที่มีปัญหาทางสังคม เช่น ไม่มีผู้พาผู้ป่วยมาพบแพทย์ไม่มีค่าพาหนะเดินทางต้องดูแลผู้สูงอายุ/คนพิการที่บ้าน ฯลฯ เป็นแพลตฟอร์มที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เชื่อมโยงกับระบบการแพทย์ทางไกล (TELEMEDICINE) หมายถึง การเชื่อมโยงระบบบริการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน อาทิ ระบบ AMED HOME WARD, HOSXP

ปฏิบัติการ SOCIAL TELECARE PLATFORM หมายถึง ระบบการดำเนินการเพื่อการพัฒนาบริการบริการคลินิกสังคมสงเคราะห์ ที่พัฒนาจากโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อขยายผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ โดยแบ่งเป็น

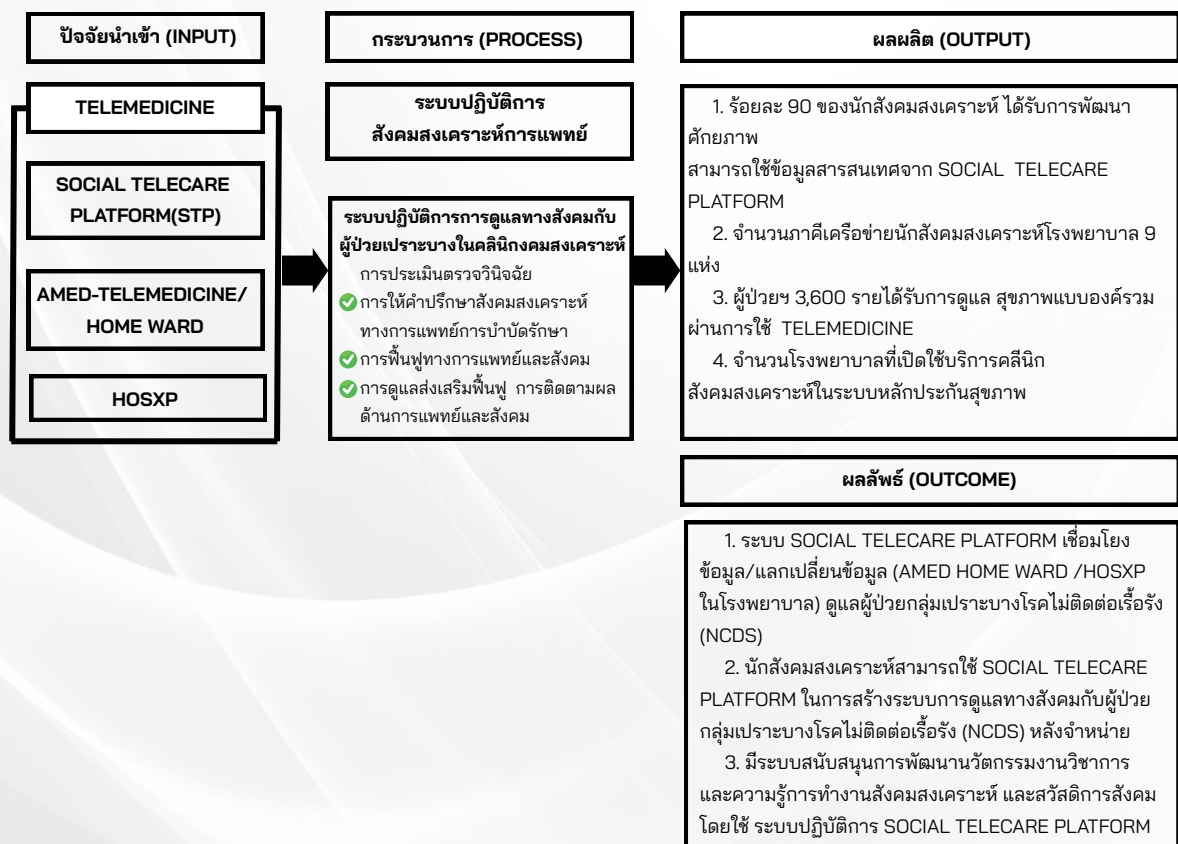
1) ระบบปฏิบัติการสำหรับประเมินปัญหาทางสังคมและปัญหาสุขภาพผ่าน PLATFORM เป็นเครื่องมือประเมินทางสุขภาพ ออกแบบบริการสุขภาพและสังคมดิจิทัล และการรับส่งข้อมูลสุขภาพแบบ ELECTRONIC FORMS ผ่าน SOCIAL TELECARE PLATFORM การทำงานของเครือข่ายการดูแลทางสังคม ในระบบบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาแบบเอกสารดิจิทัล (E-FORM, E-DOCUMENT AND E- REPORT) เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม และเครื่องมือสหวิชาชีพรวม ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดทำไว้ในระบบออนไลน์ จากผู้พัฒนาเครื่องมือทุกชิ้น

2) ใช้ได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC NOTEBOOK LAPTOP โทรศัพท์มือถือ เพื่อคัดกรอง และนำผลไปประเมิน วางแผนเพื่อบำบัดรักษา การฟื้นฟูตามมิติทางต่าง ๆ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการบำบัดสภาวะความเจ็บป่วยและฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัว และชุมชน การรับส่งต่อการรักษา การรับส่งข้อมูลสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวิชาชีพในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาล รายงานผลการสรุปแปลผล แบบดิจิทัล (E-DOCUMENT AND E-FORM E-REPORT) สำหรับกลุ่ม ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ เด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มต่างๆ ที่มีความจำเพาะในเรื่องสุขภาพต้องดูแลทางการแพทย์และสังคม และ API เชื่อมข้อมูลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (HIS) ระหว่าง โรงพยาบาล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานภายใต้พื้นที่ทดลองดำเนินการ (ระดับตติยภูมิ ทุตติยภูมิ ปฐมภูมิ และชุมชนของจังหวัด) ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยบริการสุขภาพในสังกัดอื่นๆ และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาบริการสังคมสงเคราะห์ในสถานพยาบาล และหรือหน่วยบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิด



3. ความสำคัญของปัญหางานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นิยามเชิงปฏิบัติการ

3.1 บทบาทและลักษณะงาน

นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพร่วมกับแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ โดยมีหน้าที่หลักในการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลทางสังคมเพื่อออกแบบแผนการดูแลที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย งานนี้ครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ การดูแลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ การวินิจฉัยปัญหาทางสังคม ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้รับบริการ การประสานงานและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมในด้านการปรับตัวและการสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม, เวชศาสตร์ครอบครัว ชุมชนในสังคม

3.2 หลักการวินิจฉัยและประเมินปัญหาทางสังคม

งานวินิจฉัยปัญหาทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ มีความสำคัญในการระบุปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ โดยใช้แนวทางของ ICF (INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH) เพื่อจำแนกปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้มักทำผ่านการสัมภาษณ์ การสังเกต และการใช้แบบสอบถามที่มีมาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้รับบริการและเป็นพื้นฐานในการวางแผนการแทรกแซง ออกแบบบริการดูแลที่เหมาะสม เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (ความแตกแยกในครอบครัว, ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร) ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพ (ที่อยู่อาศัย, สิ่งแวดล้อม) ปัญหาทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ ปัญหาทางกฎหมายและปัญหาสารเสพติด

3.3 การวางแผนและออกแบบบริการ

เมื่อผลการประเมินและวินิจฉัยปัญหาทางสังคมได้รับการสรุปแล้ว นักสังคมสงเคราะห์ร่วมกับทีมสุขภาพจะออกแบบแผนการดูแลหรือ INDIVIDUAL CARE PLAN ที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการ แผนบริการนี้อาจประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่นการให้คำปรึกษา (COUNSELING) และการบำบัดทางจิตใจ (PSYCHOTHERAPY) การจัดการทรัพยากรทางสังคมและการพิทักษ์สิทธิ์ การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อหาสวัสดิการหรือบริการสนับสนุนเพิ่มเติม การฝึกอบรมทักษะการปรับตัวและการสร้างความสัมพันธ์ในสังคมโดยใช้แนวคิด “PERSON IN ENVIRONMENT” เป็นต้น

3.4 การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม

นอกจากการให้บริการโดยตรงแล้ว นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ยังมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล ผ่านการฝึกอบรมและการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการในอนาคต การแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ และการใช้หลักมาตรฐานเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้วิชาชีพนี้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. แนวโน้มและโอกาสด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ระบบ SOCIAL TELECARE ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

- ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (TELECONSULTATION) : ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอล แชท หรือโทรศัพท์ได้
- ระบบติดตามและบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (E-CASE MANAGEMENT) : การจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยและปัญหาทางสังคมในรูปแบบดิจิทัล ช่วยให้การวิเคราะห์และติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบส่งต่อข้อมูล (REFERRAL SYSTEM) : เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยกับหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ ช่วยลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลาการให้บริการ และสามารถให้บริการในรูปแบบ REAL TIME ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
- การปรับปรุงและพัฒนาาระบบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการนำ AI, BIG DATA, LLM และ VIRTUAL REALITY มาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลและการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติ

การออกแบบระบบ PLATFORM SOCIAL TELECARE บทที่ 2

การออกแบบระบบ PLATFORM SOCIAL TELECARE เพื่อสนับสนุนการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพ 5 ระบบหลักและ 40 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วินิจฉัย และให้บริการทางสังคมและสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและเชื่อมโยงกับแผนการรักษาทางการแพทย์ ดังนี้

1. โครงสร้างระบบ PLATFORM SOCIAL TELECARE

การแสดงความจำนงค์ขอเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง

1.1 เอกสารที่ต้องเตรียม

- บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานมหาวิทยาลัย/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐออกให้ไว้เพื่อแสดงตัวตน

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

* หมายเหตุ ต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น (.JPG หรือ .PNG)

1.2 ระบบสมัครสมาชิก

รูปที่ 1 หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานระบบและสมัครเข้าใช้งาน



หนังสือแสดงความจำนงค์ขอใช้งาน
ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง
และ ให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า นาย กิรพัทธ์ วรวิทย์ไกลกุล เลขประจำตัวประชาชน 1250100376289 อยู่บ้านเลขที่ ห้อง A709
Hiso place

99 ม.17 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หมายเลขโทรศัพท์ 0925635491 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้งาน" ขอแสดงความจำนงค์ขอใช้งานระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง และ ให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อ โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "โครงการฯ" ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงค์ขอใช้งาน ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
2. ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล เป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคล นั้นโดยตรง หรือ มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใดจะอาศัยอำนาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือกฎหมายอื่นเพื่อขอเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้
3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อการกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปี เกิด รูปถ่าย
4. ผู้ใช้งาน ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในโครงการฯ โดยข้อมูลส่วนบุคคลมีอายุการเก็บรวบรวมตลอดระยะเวลาของโครงการฯ หากผู้ใช้งานไม่แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3 จะไม่สามารถ ใช้งานระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง ได้
5. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลจะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 ข้างต้น หรือตามหมายเรียกคำสั่งของศาลหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น
6. ผู้ใช้งานมีสิทธิดังต่อไปนี้
 - 6.1 ถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอม ย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งาน ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบตามที่กำหนดไว้
 - 6.2 ขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอม
 - 6.3 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากโครงการฯ ได้ ในกรณีที่โครงการฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 - 6.4 คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่กฎหมายอนุญาตให้เก็บได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากโครงการฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
 - 6.5 ขอให้ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ตามมาตรา 33 ววรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 - 6.6 ขอให้ดำเนินการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด
 - 6.7 แจ้งให้ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 - 6.8 มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่โครงการฯ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - 6.9 ผู้ใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-613-2500 โทรสาร 02-224-9417 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ socialtelecare@gmail.com

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแสดงความจำนงค์ขอใช้งาน ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง และ ให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของ หนังสือฉบับนี้เป็นอย่างดี จึงลงลายมือชื่อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นสำคัญ

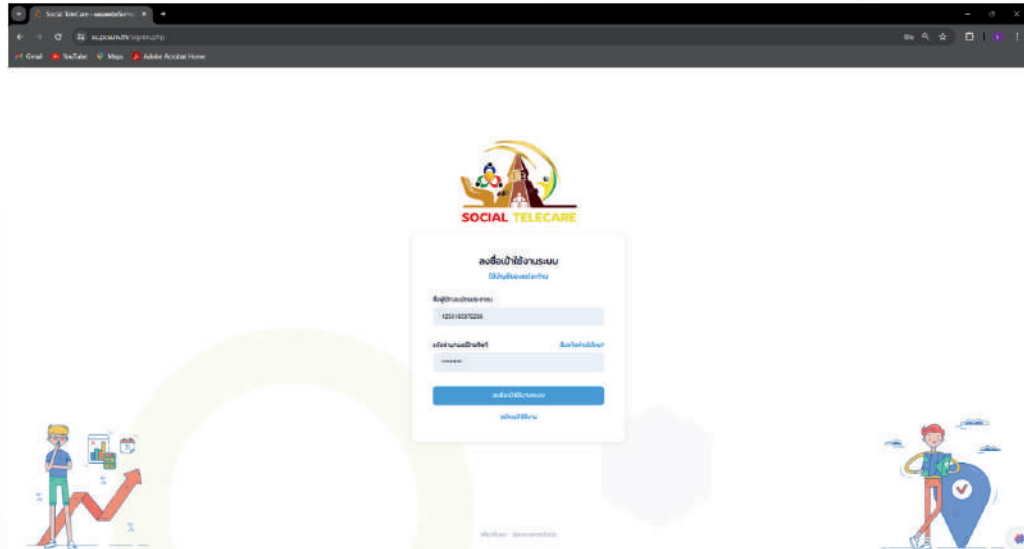


นาย กิรพัทธ์ วรวิทย์ไกลกุล
(นาย กิรพัทธ์ วรวิทย์ไกลกุล)
ผู้ใช้งาน

รูปที่ 2 หนังสือแสดงความจำนงค์ขอใช้งานระบบ

2. ระบบแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลคนกลุ่มเปราะบาง (ระบบประเมินและเมนูพื้นฐานต่างๆ)

2.1 หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

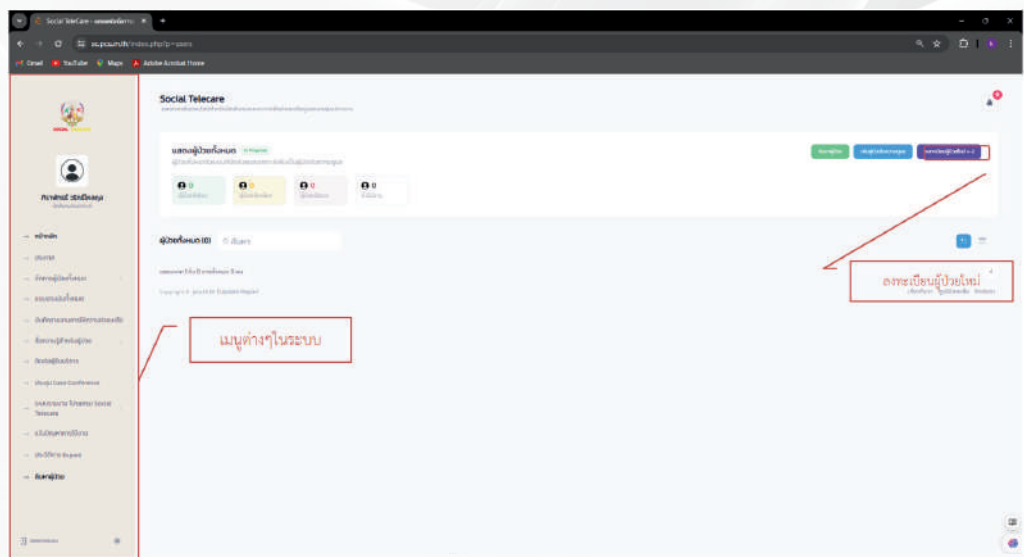


รูปที่ 3 หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

หน้าต่างลงชื่อเข้าใช้งานระบบ มีรายละเอียดดังนี้

- สามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทาง [HTTP://SC.PCU.IN.TH/SIGNIN.PHP](http://SC.PCU.IN.TH/SIGNIN.PHP)
- กรอกข้อมูลลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์หรือสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตามต้องการได้

2.2 หน้าหลัก



รูปที่ 4 หน้าต่างหลัก

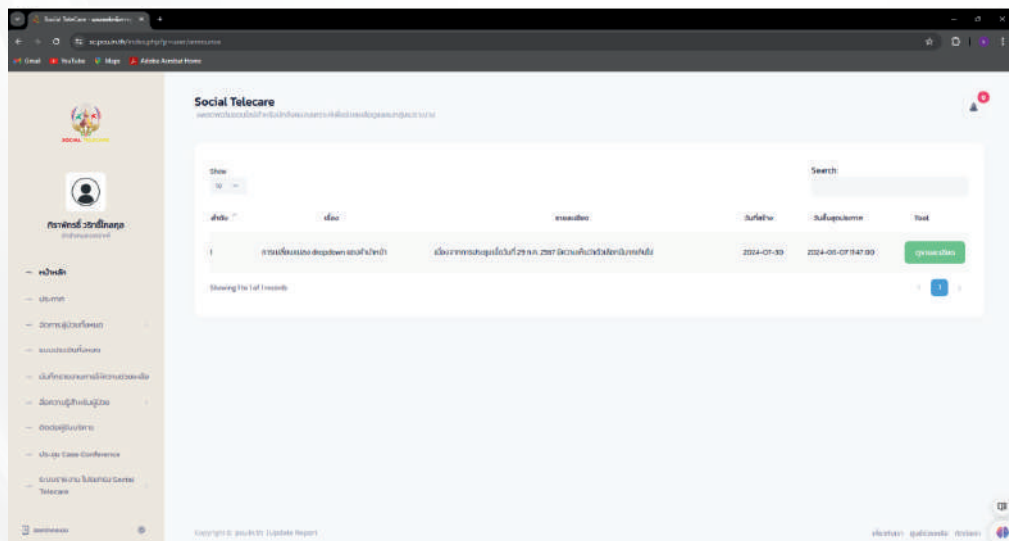
เมนูต่างๆในระบบ ประกอบด้วย

- หน้าหลัก
- ประกาศ
- จัดการผู้ป่วยทั้งหมด
- บันทึกการรายงานการให้ความช่วยเหลือ

เมนูต่างๆในระบบ ประกอบด้วย

- สื่อความรู้สำหรับผู้ป่วย
- ติดต่อผู้รับบริการ
- ประชุม CASE CONFERENCE
- ระบบรายงานโปรแกรม SOCIAL TELECARE
- แจ้งปัญหาการใช้งาน
- ประวัติการ EXPORT ข้อมูล
- ค้นหาผู้ป่วย

2.3 ประกาศ

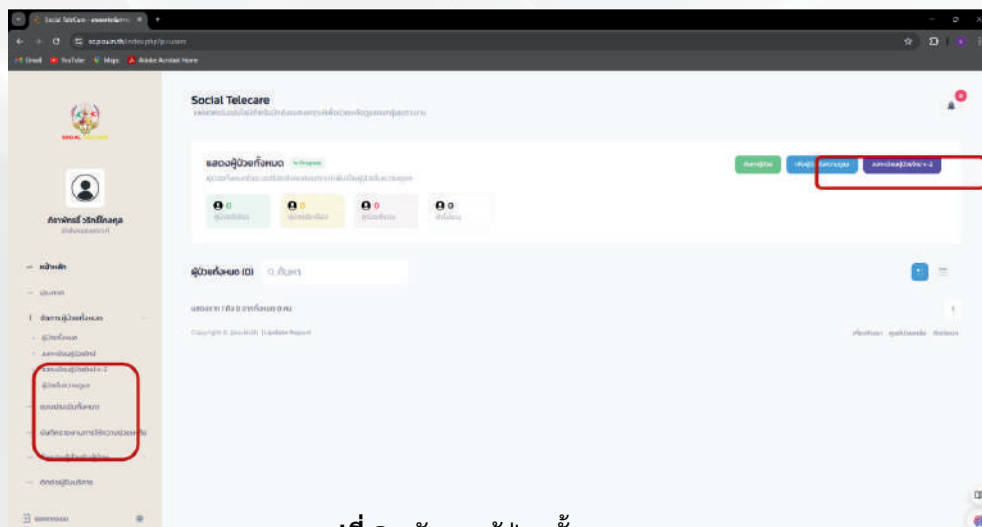


รูปที่ 5 หน้าต่างเมนูประกาศ

หน้าต่าเมนูประกาศ

- เป็นหน้าต่าแจ้งเตือนการปรับปรุงระบบต่างๆจากผู้ดูแลระบบ และทีมผู้พัฒนาว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆในระบบบ้าง

2.4 จัดการผู้ป่วยทั้งหมด



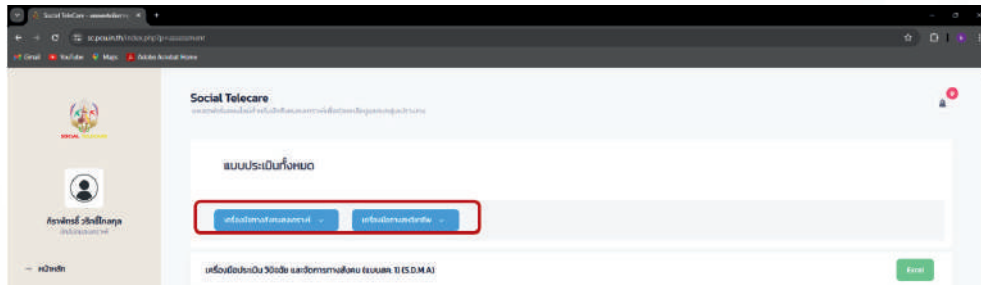
รูปที่ 6 จัดการผู้ป่วยทั้งหมด

หน้าต่าเมนูจัดการผู้ป่วยทั้งหมด

- ผู้ป่วยทั้งหมด แสดงผู้ป่วยทั้งหมดในความดูแล
- ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ เป็นเมนูเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยเดียวกับกล่องสี่ฟาด้านขวาม

- ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ เป็นเมนูเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับกล่องสีม่วงด้านขวาบน (แนะนำให้ใช้เมนูนี้)
- เมนูผู้ป่วยในความดูแล (จะไปยังหน้าหลักที่แสดงผู้ป่วยในความดูแลทั้งหมด)

2.5 แบบประเมินทั้งหมด

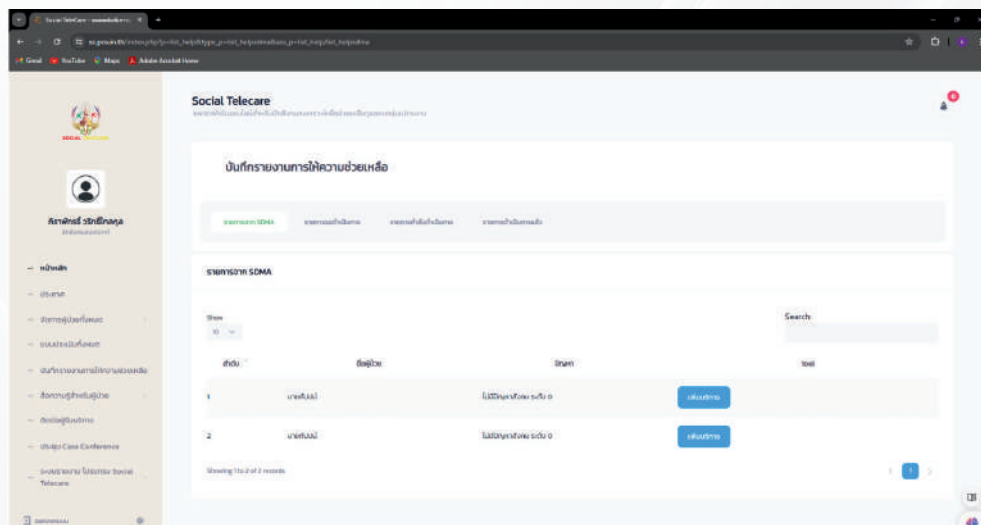


รูปที่ 7 หน้าต่างเมนูแบบประเมินทั้งหมด

หน้าต่างเมนูแบบประเมินทั้งหมด

- แสดงข้อมูลการประเมินทั้งหมดของผู้ป่วยแต่ละรายทุกแบบประเมิน
- แยกเป็นเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์และเครื่องมือทางวิชาชีพ

2.6 บันทึกการรายงานการให้ความช่วยเหลือ

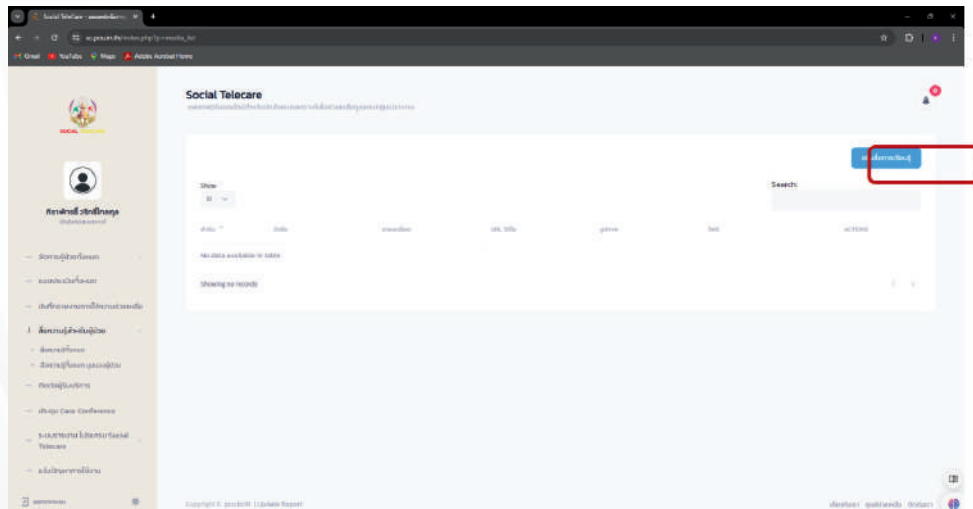


รูปที่ 8 บันทึกการรายงานการให้ความช่วยเหลือ

บันทึกการรายงานการให้ความช่วยเหลือ

- เป็นเมนูสำหรับบันทึกบริการทางสังคมสงเคราะห์ 40 บริการ
- พร้อมคิดต้นทุนการให้บริการ

2.7 สื่อความรู้สำหรับผู้ป่วย

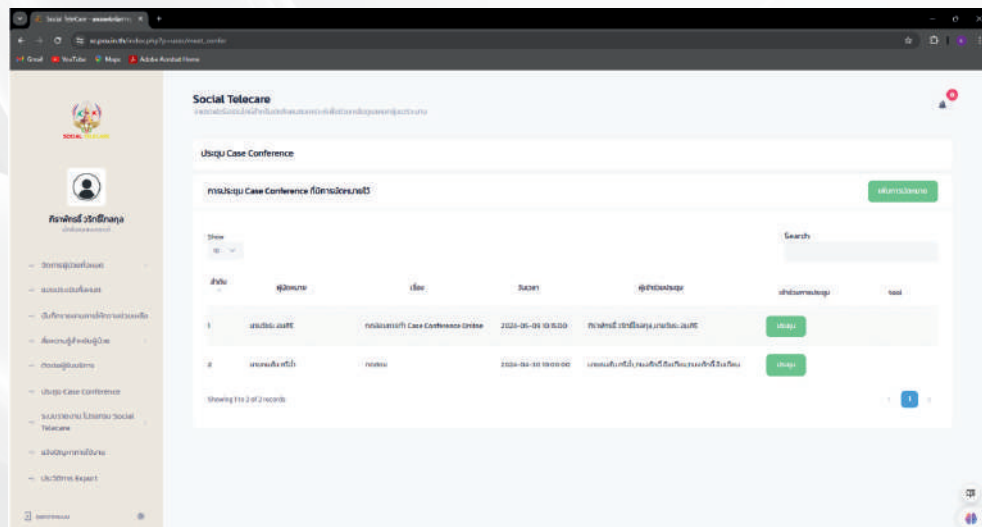


รูปที่ 9 หน้าต่างเมนูสื่อความรู้

หน้าต่างเมนูสื่อความรู้

- สามารถเพิ่มสื่อการเรียนรู้ที่ปุ่มสีฟ้าเพิ่มสื่อการเรียนรู้
- ปัจจุบันทีมผู้พัฒนากำลังทำระบบ E-LEARNING สำหรับการอบรมต่างๆเพื่อนำเข้าสู่ระบบ

2.8 ประชุม CASE CONFERENCE

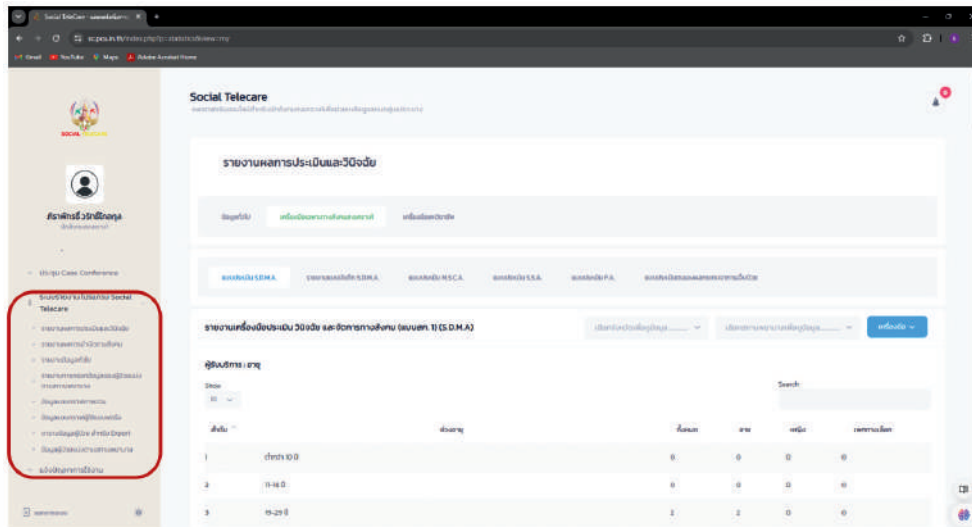


รูปที่ 10 ประชุม CASE CONFERENCE

ประชุม CASE CONFERENCE

- สามารถนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ TRUE VROOM
- เพิ่มนัดประชุมออนไลน์ตรงปุ่มสีเขียวด้านบน
- สามารถเพิ่มชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่นัดประชุมได้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ถูกนัดหมาย

2.9 ระบบรายงาน SOCIAL TELECARE

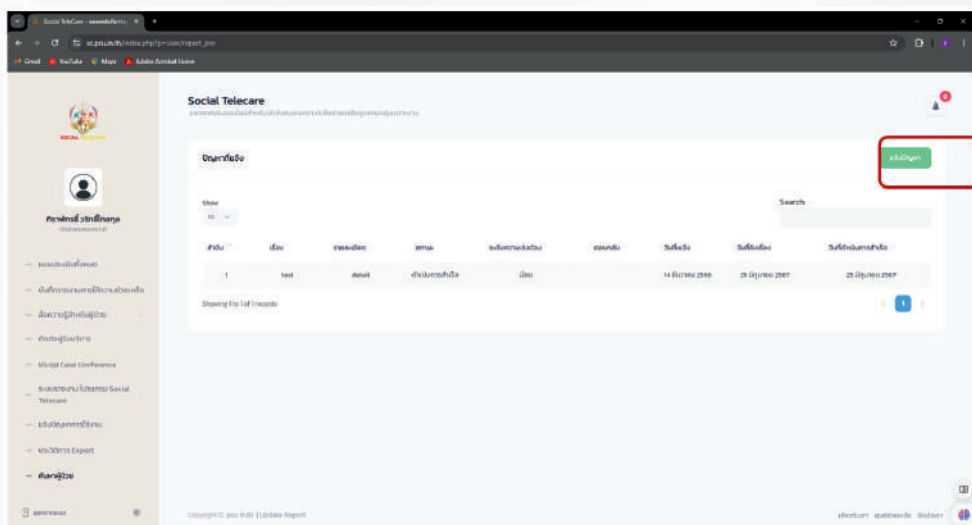


รูปที่ 11 ระบบรายงาน SOCIAL TELECARE

ระบบรายงาน โปรแกรม SOCIAL TELECARE

- รายงานผลการประเมินและวินิจฉัย
- รายงานผลการบำบัดทางสังคม
- รายงานข้อมูลทั่วไป
- รายงานการกรอกข้อมูลของผู้ป่วยแบ่งตามสถานพยาบาล
- ข้อมูลแบบกราฟภาพรวม
- ข้อมูลแบบกราฟผู้ใช้แบบฟอร์ม
- ตารางข้อมูลผู้ป่วย สำหรับ EXPORT
- ข้อมูลผู้ป่วยแบ่งตามสถานพยาบาล

2.10 แจ้งปัญหาการใช้งาน

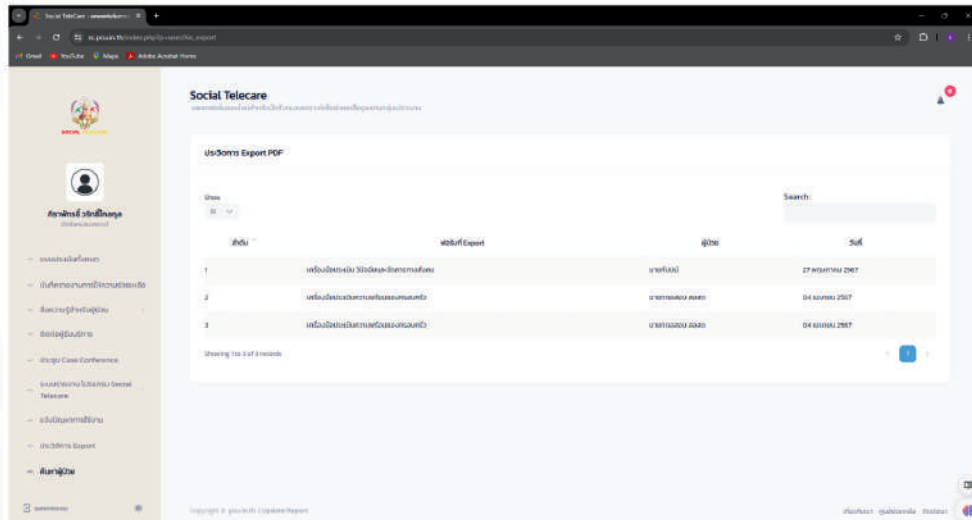


รูปที่ 12 แจ้งปัญหาการใช้งาน

แจ้งปัญหาการใช้งาน

- สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆได้
- กดปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนขวาเพื่อแจ้งปัญหา
- ผู้ดูแลระบบจะรับทราบปัญหา เพื่อดำเนินการแก้ไข

2.11 ประวัติการ EXPORT ข้อมูล

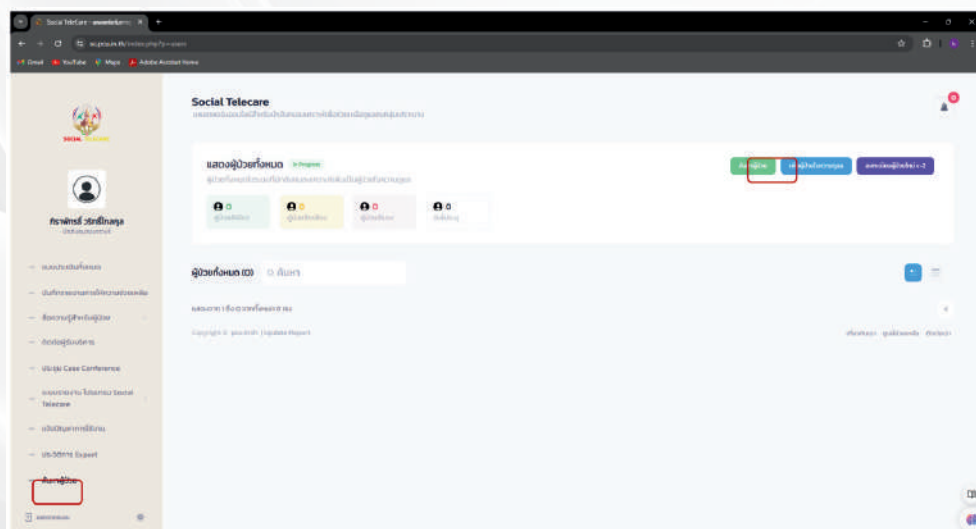


รูปที่ 13 ประวัติการ EXPORT ข้อมูล

ประวัติการ EXPORT ข้อมูล

- สามารถดูประวัติการนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้
- ลำดับรายการแต่ละแบบประเมินที่ถูก EXPORT

2.12 ค้นหาผู้ป่วย



รูปที่ 14 ค้นหาผู้ป่วย

ค้นหาผู้ป่วย

- สามารถค้นหาผู้ป่วยโดยกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยที่ต้องการค้นหาว่ามีในระบบแล้วหรือยัง
- เพื่อรับ CASE ต่อไปดูแลจากนักสังคมสงเคราะห์ท่านอื่น

3. โครงสร้างระบบกิจกรรมทางสังคม PLATFORM SOCIAL TELECARE

ระบบประกอบด้วยโมดูลหลักที่สอดคล้องกับ 5 ระบบ ดังนี้

3.1 ระบบการประเมินและวินิจฉัยทางสังคม

● กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การประเมินปัญหาทางสังคม, การประเมินความพร้อมของครอบครัว, การประเมินทักษะทางสังคม, การประเมินสุขภาพจิตตนเอง

● ฟังก์ชันการทำงาน

- แบบประเมินออนไลน์ : ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถกรอกแบบประเมินทางสังคมผ่านแพลตฟอร์มได้
- การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ : ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินและให้คะแนนความเสี่ยงทางสังคม
- การแจ้งเตือน : แจ้งเตือนทีมสหวิชาชีพเมื่อพบปัญหาสังคมที่รุนแรง เช่น ความยากจน, การขาดแคลนที่อยู่อาศัย, ปัญหาครอบครัว

3.2 ระบบการให้คำปรึกษาและบำบัดทางสังคม

● กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การให้คำปรึกษารายบุคคล, การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์/ออนไลน์, การบำบัดทางสังคม, การเสริมพลังอำนาจ

● ฟังก์ชันการทำงาน

- การนัดหมายออนไลน์ : ผู้ป่วยสามารถนัดหมายกับนักสังคมสงเคราะห์หรือทีมสหวิชาชีพผ่านแพลตฟอร์ม
- การบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษา

3.3 ระบบการฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคม

● กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง: การฝึกทักษะทางสังคม, การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง, การจัดการทรัพยากรทางสังคม

● ฟังก์ชันการทำงาน

- แผนการฟื้นฟูแบบดิจิทัล : สร้างแผนการฟื้นฟูที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ป่วย
- การติดตามผล: ติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์
- การเชื่อมโยงกับชุมชน : เชื่อมโยงผู้ป่วยกับแหล่งทรัพยากรในชุมชน เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ , ศูนย์ฝึกอาชีพ

3.4 ระบบการดูแลส่งเสริมและฟื้นฟู

● กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : การเยี่ยมบ้าน, การจัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ, การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต

● ฟังก์ชันการทำงาน

- การบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน : บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านและปัญหาที่พบ
- การแจ้งเตือน : แจ้งเตือนทีมสหวิชาชีพเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพหรือสังคมที่ต้องแก้ไข
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแผนการดูแลให้เหมาะสม

3.5 ระบบติดตามผลด้านการแพทย์และสังคม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง : การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต, การป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ, การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังจำหน่าย

ฟังก์ชันการทำงาน

- การติดตามผลออนไลน์: ผู้ป่วยสามารถรายงานอาการและปัญหาสังคมผ่านแพลตฟอร์ม
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการรักษา
- การเชื่อมโยงกับแผนการรักษา: เชื่อมโยงข้อมูลทางสังคมกับแผนการรักษาทางการแพทย์

การวินิจฉัย เครื่องมือ และบริการทางสังคมผ่าน PLATFORM SOCIAL TELECARE

บทที่ 3

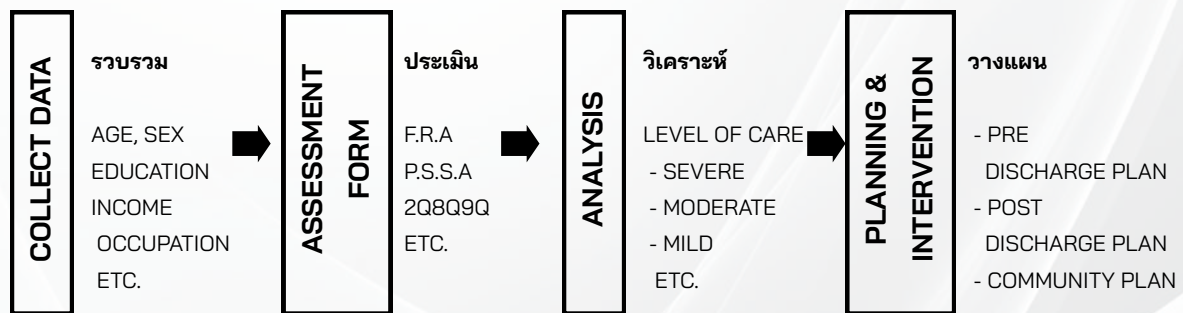
1. การวินิจฉัยทางสังคมใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

การวินิจฉัยทางสังคม (SOCIAL DIAGNOSIS) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดูแลและสนับสนุนที่เหมาะสม แนวทางการวินิจฉัยทางสังคมสามารถสรุปได้ ดังนี้

1.1 วัตถุประสงค์ของการวินิจฉัยทางสังคม

- เพื่อระบุปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย
- เพื่อเข้าใจบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่
- เพื่อวางแผนการดูแลและสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมที่อาจส่งผลการรักษาพยาบาล

1.2 ขั้นตอนคัดกรองเพื่อการวินิจฉัยทางสังคม



RAPID SCREENING IN SOCIAL DIAGNOSIS PROCESS

RAPID SCREENING IN SOCIAL DIAGNOSIS PROCESS คือ ขั้นตอนการประเมินหรือคัดกรองปัญหาทางสังคมเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว เพื่อระบุปัญหาทางสังคม ความต้องการเบื้องต้นของบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการรักษาเบื้องต้น โดยใช้แบบคัดกรองที่ได้ รับการรับรองทางวิชาชีพ โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล

- ข้อมูลส่วนตัว : อายุ, เพศ, สถานภาพสมรส, ระดับการศึกษา, อาชีพ
- ข้อมูลทางเศรษฐกิจ : รายได้, หนี้สิน, การเข้าถึงสวัสดิการสังคม
- ข้อมูลทางสังคม : ความสัมพันธ์ในครอบครัว, การสนับสนุนทางสังคม, ปัญหาความขัดแย้ง
- ข้อมูลสิ่งแวดล้อม : ที่อยู่อาศัย, สภาพแวดล้อมในชุมชน, การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
- ข้อมูลสุขภาพ : ประวัติการเจ็บป่วย, การรักษาพยาบาล, การใช้ยาหรือสารเสพติด

(2) ตัวอย่างการประเมินปัญหา

- ใช้เครื่องมือประเมินทางสังคม เช่น แบบประเมินความพร้อมของครอบครัว (FAMILY READINESS ASSESSMENT), แบบประเมินทักษะทางสังคม (SOCIAL SKILL ASSESSMENT) เป็นต้น
- ระบุปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ความยากจน, การว่างงาน, การขาดแคลนที่อยู่อาศัย, ปัญหาครอบครัว

(3) ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสังคมและสุขภาพ

- ระบุปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุนทางสังคม
 - ประเมินความรุนแรงของปัญหาและความเร่งด่วนในการแก้ไข
- (4) ตัวอย่างการวางแผนการดูแล
- จัดทำแผนการดูแลที่สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมที่พบ
 - เชื่อมโยงผู้ป่วยกับทรัพยากรและบริการทางสังคม เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, ศูนย์ฟื้นฟูและฝึกอาชีพ
 - ปรับแผนการรักษาทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของผู้ป่วย

1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยทางสังคม

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ
1) เครื่องมือประเมิน วินิจฉัยและจัดการทางสังคม (Social Diagnosis and Management Assessment) S.D.M.A.	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกราย
2) เครื่องมือประเมินความพร้อมของครอบครัว (Family Readiness Assessment :F.R.A.)	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรง
3) เครื่องมือแบบประเมินทักษะพื้นฐานในการทำงานและทักษะการปรับตัวทางสังคม (Social skill Assessment : S.S.A.)	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1. คนพิการ (7) 2. ผู้ป่วยจิตเวช(4)
4) เครื่องมือประเมินการดูแลสุขภาพจิตตนเอง (Mental Self Care Assessment : M.S.C.A.)	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1. คนพิการ (7) 2. ผู้ป่วยจิตเวช(4)
5) เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคมผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/โรคติดต่อร้ายแรง	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ผู้ป่วย Postโควิด (1)
6) ประเมินตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วย	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกราย
7) แบบฟอร์มการส่งต่อข้อมูลทางสังคม	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรง ที่ต้องการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8) แบบติดตามและประเมินทางสังคม (Social Monitoring and evaluation) กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดสำหรับนักสังคมสงเคราะห์	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
9) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (2-Q9Q8Q)	ทีมสหวิชาชีพ	1.ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรง 2. ผู้ที่มีอาการอาการซึมเศร้าชัดเจน 3. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ 4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ
		5. ผู้ป่วยสูงอายุ 6. หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 7. ผู้ที่มีปัญหาสายตาเลือนราง 8. ผู้ที่ประสบกับการสูญเสียที่รุนแรงมาไม่นาน
10) การทำผังครอบครัว การทำแผนที่สังคม มิติ และ Life Time	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกราย
11) แบบสรุปประชุมทีมสหวิชาชีพ (conference case)	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรง
12) แบบประเมินสมรรถนะคนพิการ (International Classification of Functioning Disability and Health : ICF)	ทีมสหวิชาชีพ	1. คนพิการ (7)
13) แบบประเมินกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Stroke :Trauma brain injury : Spinal cord injury: Fracture around the hip
14) แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ฉบับสวนดอก (Palliative performance Score: PPS Score) holistic care model	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้หรือรักษาไม่หาย ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยเรื้อรังที่โรคดำเนินมาจนถึงระยะท้าย ผู้ป่วยที่มีเวลาเหลือไม่นาน ผู้ป่วยโรคชรา (ร่างกายเสื่อมถอย) : ผู้ป่วย Stroke เส้นเลือดในสมองแตก หรือเกิดอุบัติเหตุและสมองตาย
15) แบบ ST5 แบบประเมินความเครียด	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/ รุนแรง
16) แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปี ขึ้นไป
17) แบบ Advance care plan การวางแผนล่วงหน้าของผู้ป่วยระยะท้าย	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยระยะท้าย
18) เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/ รุนแรง

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ
19) แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ (Child maltreatment surveillance tool : CMST)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยเด็ก/ผู้ป่วยเด็กและถูกกระทำรุนแรงทุกราย
20) แบบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่เข้ารับบริการ ศูนย์พึ่งได้	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทุกราย
21) แบบคัดกรองความรุนแรงในครอบครัว Woman Abuse Screening Tool (WAST) version ภาษาไทย	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
22) แบบบันทึกการลงข้อมูลผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่เข้ารับบริการศูนย์พึ่งได้	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยตั้งครรภ์ไม่พร้อมทุกราย
23) แบบคัดกรองความรุนแรงในครอบครัว	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง
24) แบบคัดกรองตามการวินิจฉัย DSM -5 ในผู้ช้ำยาและ สารเสพติด	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยช้ำยาและสารเสพติด
25) แบบประเมินอาการทางจิต (BPRS)	พยาบาลวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
26) แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (OAS)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
27) แบบประเมินสภาวะทางจิตของผู้ป่วยจิตเวช (HoNOS)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
28) แบบประเมินความรุนแรงอาการทางจิต (CGI-S)	จิตแพทย์	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
29) แบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท (F20-F29) (PANSS)	พยาบาล	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
30) แบบประเมินการความรุนแรงของความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย (TMRS)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
31) แบบประเมินส่วนประกอบทางอารมณ์ (MOSAIC)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า Major depressive disorder, s ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
32) แบบวัดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท/ญาติ (Burden of care)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
33) แบบประเมินระดับความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา (CIWA-Ar)	พยาบาล /จิตแพทย์	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
34) แบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา (AWS)	พยาบาล /จิตแพทย์	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ
35) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยยาเสพติด
36) แบบประเมินอาการเตือนการกำเริบซ้ำของโรคติดสุรา (AWARE -Thai)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
37) แบบติดตามผู้ป่วยจิตเวช เรื้อรังในชุมชน 10 ด้าน	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด
38) แบบประเมินความเสี่ยงทางคลินิก (SAVE)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช

1.4 ตัวอย่างปัญหาทางสังคมที่พบในการวินิจฉัย

- ปัญหาด้านเศรษฐกิจ : รายได้ต่ำ, การว่างงาน, หนี้สิน
- ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย : ไม่มีที่อยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
- ปัญหาด้านครอบครัว : ความขัดแย้งในครอบครัว, การขาดการสนับสนุนจากครอบครัว
- ปัญหาด้านการศึกษา : การไม่รู้หนังสือ, การขาดโอกาสหรือมีอุปสรรคทางการศึกษา
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม : การอยู่ในพื้นที่มลพิษสูง, การขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด, สิ่งแวดล้อม

มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดหรืออบายมุข

2. แนวทางการวินิจฉัยทางสังคมใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

แนวทางการวินิจฉัยทางสังคม (SOCIAL DIAGNOSIS) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นการเข้าใจบริบททางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การวางแผนการดูแลและสนับสนุนที่เหมาะสมแนวทางการวินิจฉัยทางสังคมสามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 รหัสรายการประเมินวินิจฉัยตามแบบบัญชีปัญหาทางสังคม

รหัส ICF	รายการ	ความหมาย
d770	ปัญหาคู่สมรสและการครองเรือน	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในคู่สมรสและการจัดการครอบครัว เช่น ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ การสื่อสารที่ผิดพลาด หรือความไม่ลงรอยในการบริหารครอบครัว
d760	ปัญหาระหว่างบิดามารดา บุตร	ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดระหว่างบิดามารดากับบุตร ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการในครอบครัว
e310	ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว	กลุ่มปัจจัยสิ่งแวดล้อมนี้ใช้สำหรับอธิบายสถานการณ์ที่เกิดความแตกแยกหรือความไม่สามัคคีภายในครอบครัว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว
d7603	ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือการสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวขยาย (เช่น ญาติพี่น้อง, ลุง, ป้า) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกสนับสนุนและความเป็นอยู่

รหัส ICF	รายการ	ความหมาย
d7700	ปัญหาความรัก	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลหรือการตีตราทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
d7702	ปัญหาทางเพศ	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศหรือปัญหาด้านเพศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
d650	ปัญหาภาระในการดูแลผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ/ผู้สูงอายุในครอบครัว	ภาระหรือความเครียดที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะเจ็บป่วยหรือพิการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ของผู้ดูแล
e160	ปัญหาที่อยู่อาศัย/สภาพแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสุขภาพ	ระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงหรือเป็นภัยต่อสุขภาพของบุคคล
d750	ปัญหาที่เกิดจากบุคคลอื่นนอกครอบครัว	ปัญหาที่เกิดจากการกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือความเป็นอยู่ของผู้รับบริการ
d870	ปัญหาการเงิน	ปัญหาด้านการเงิน การบริหารจัดการทรัพยากร หรือปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจเป็นสาเหตุหรือปัจจัยร่วมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต
d820	ปัญหาการศึกษา	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษา คุณภาพของการศึกษา หรืออุปสรรคในการพัฒนาทักษะและความรู้
d845	ปัญหาการประกอบอาชีพ	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหางานหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการขาดทักษะหรือความไม่มั่นคงในการทำงาน
e550	ปัญหาทางกฎหมาย	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปัญหาด้านกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความปลอดภัยของบุคคล
d660	ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย	ใช้สำหรับระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงหรือการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วย
d930	ปัญหาความเชื่อ วัฒนธรรม และการเมือง	วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อส่วนบุคคล วัฒนธรรม หรือสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการมีส่วนร่วมทางสังคม
Z722	ปัญหาสารเสพติด/สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท	ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดหรือสารที่มีผลต่อจิตประสาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมชีวิตและสุขภาพจิต
d235	ปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม/ปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับสภาวะทางจิตและสังคม	รหัสนี้ใช้สำหรับกรณีที่ปัญหาทางสังคมซับซ้อนหรือไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ระบุไว้ข้างต้นได้ เช่น ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือพฤติกรรม

2.2 กลุ่มเปราะบาง (VULNERABLE GROUPS)

เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาสุขภาพและสังคม เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักต้องการการสนับสนุนและบริการทางสังคมสงเคราะห์เป็นพิเศษ และปัญหาซับซ้อนที่เกี่ยวข้อง พร้อมการวินิจฉัยทางสังคมตาม ICD-10 และบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่สัมพันธ์กัน

ตารางแสดง กลุ่มผู้ป่วยและICD-10 (ตัวอย่างรหัส) ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	กลุ่มเปราะบาง	ICD-10 (ตัวอย่างรหัส)	คำแปล ICD-10 เป็นภาษาไทย
1	ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อ HIV	B20-B24	การติดเชื้อเอชไอวี / โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัส
2	แม่วัยรุ่น/หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	Z32.2, Z64.0	การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ / ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิต
3	ผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ	Z60.3, Z75.3	ปัญหาทางสังคม / สถานะการอพยพและการเข้าถึงบริการไม่เพียงพอ
4	ผู้ป่วยต่างชาติ	Z60.3	สถานะการย้ายถิ่นฐาน หรือปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรม
5	ผู้พิการ	Z73.6, F70-F79, Q00-Q99	ความบกพร่องทางร่างกาย/สติปัญญา/ความพิการแต่กำเนิด
6	ผู้ถูกระทำทารุณกรรมรุนแรงในครอบครัว	T74.x, Y07.x	การถูกระทำทารุณกรรม / ความรุนแรงในครอบครัว
7	ผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด	F10-F19	ความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์และสารเสพติด
8	ผู้ป่วยไร้บ้าน	Z59.0	ไม่มีที่อยู่อาศัย
9	ผู้ต้องขัง / ศูนย์พินิจ / สถานกักกัน	Z65.2, Z65.4	ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและความยุติธรรม
10	ผู้สูงอายุ	Z72.0, R54	ผู้สูงวัย / ความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย
11	ผู้ป่วยโรค	A15-A19	โรคปอดและอวัยวะอื่น
12	ผู้ป่วยระยะประคับประคอง	Z51.5, R68.8	การดูแลแบบประคับประคอง / อาการทั่วไปที่ไม่ระบุสาเหตุ
13	ผู้ป่วยโรคโควิด-19	U07.1, U07.2	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14	ผู้ป่วยจิตเวช	F20-F99	ความผิดปกติทางจิตเวช เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์สองขั้ว ซึมเศร้า
15	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	E10-E14, I10-I15, N18	เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไตวายเรื้อรัง ฯลฯ
16	ผู้ไร้สถานะทางกฎหมาย	Z65.1, Z75.3	ปัญหาทางกฎหมาย / ไม่มีเอกสารระบุตัวตน
17	ผู้ถูกทอดทิ้ง	Z60.2, Z62.4	ขาดการดูแลจากครอบครัว / ถูกทอดทิ้ง
18	ผู้ป่วยมะเร็ง	C00-C97	มะเร็งทุกประเภท เช่น มะเร็งเต้านม ปอด ตับ ฯลฯ

2.3 การวินิจฉัยทางสังคมที่สัมพันธ์กับ ICD-10

ICD-10 ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยทางสังคมที่พบบ่อย เช่น

- Z590 ไม่มีบ้าน/เร่ร่อน/ไม่มีเลข 13 หลัก
- Z595 ยากจนมาก
- Z596 รายได้ต่ำ
- Z602 อยู่คนเดียว
- Z630 สามี/ครอบครัวทำร้าย (ผู้ใหญ่)
- Z640 ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
- Z736 ปัญหาความพิการ
- Z992 พึ่งพาการฟอกไต
- Z993 พึ่งพารถเข็น
- Y05 ถูกกระทำชำเราทางเพศ (ผู้ใหญ่)
- Y06 ถูกทอดทิ้ง

ฯลฯ

ตารางแสดง กลุ่มผู้ป่วยและ ICF (ตัวอย่างรหัส) ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย	รหัส ICF ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง)
1. ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS	b130, b152, b280, d850, e580
2. แม่วัยรุ่น/ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	b640, d750, e310, e355, d760
3. แรงงานข้ามชาติ	d710, d720, e340, e580, d845
4. ผู้ป่วยต่างชาติ	e310, e355, d750, b180
5. คนพิการ	ขึ้นกับความพิการ เช่น b710-b729, d450-d469
6. ถูกกระทำความรุนแรง (OSCC)	b152, b180, e310, d240, d750
7. ผู้ใช้สารเสพติด	b130, b152, b280, d710, e110, e580
8. คนไร้บ้าน	e155, e165, d850, e340, d760
9. ผู้ต้องขัง	d720, e150, b152, e540
10. ผู้สูงอายุ	b710, d450, d540, e310, e580
11. วัณโรค	b440, b430, d450, e110, e580
12. ผู้ป่วยระยะท้าย	b130, b280, d850, e310, e580
13. โควิด-19/โรคอุบัติใหม่	b440, d450, b130, e580
14. ผู้ป่วยจิตเวช	b152, b180, d720, e310, d750
15. โรคเรื้อรัง (เบาหวาน, หัวใจ ฯลฯ)	b540, b410, d450, e580

ตารางแสดง กลุ่มผู้ป่วยและ ICF (ตัวอย่างรหัส) ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กลุ่มเป้าหมาย	รหัส ICF ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง)
16. ไร้สถานะทางกฎหมาย	e580, e165, d850, d760
17. ถูกทอดทิ้ง	d760, d710, e310, e580
18. ผู้ป่วยมะเร็ง	b130, b280, b455, b530, d230, d450, d850, e310, e580

2.4 บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เบิกจ่ายตามสิทธิของผู้รับบริการและควบคุมค่าใช้จ่ายของกองทุนต่างๆ ประกาศนี้ครอบคลุม บริการสังคมสงเคราะห์ 40 รายการ (ทั้งในหมวดเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสุขภาพจิต/ จิตเวช) เพื่อให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลมีมาตรฐาน และรองรับระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน รวมถึงเป็นข้อมูลอ้างอิงให้โรงพยาบาล และวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใช้ในการให้บริการ แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น สามารถออกแบบหรือเพิ่มหน้าต่างบริการ (SERVICE WINDOW) ระบบสังคมสงเคราะห์ (SOCIAL WORK MODULE) ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HOSPITAL INFORMATION SYSTEM : HIS) เพื่อบันทึกบริการสังคมสงเคราะห์ ในคลินิกสังคมสงเคราะห์ในระบบ HIS ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบครอบคลุมข้อมูลผู้ป่วย การให้บริการทางการแพทย์ การเงิน การบริหาร และระบบสนับสนุนอื่นๆ เป็นการลดการใช้เอกสารกระดาษ เพิ่มความแม่นยำในการดูแลรักษานับสนุนการเบิกจ่ายจากกองทุน เช่น สปสช. สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง เชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ระบบบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แบ่งเป็น 5 ระบบหลัก ได้แก่

1. ระบบการประเมินตรวจวินิจฉัย (7 บริการ) เช่น การประเมินปัญหาทางสังคม, การประเมินความพร้อมของผู้ป่วย/ครอบครัว
2. ระบบการให้คำปรึกษาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (17 บริการ) เช่น การให้คำปรึกษารายบุคคล, การทำจิตบำบัด, การสนับสนุนทางสังคม
3. ระบบการฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคม (12 บริการ) เช่น การฝึกทักษะทางสังคม, การจัดทำแผนดูแลทางสังคม
4. ระบบการดูแลส่งเสริมฟื้นฟู (2 บริการ) เช่น การเยี่ยมและจัดทำแผนดูแลส่งเสริมสุขภาพ
5. ระบบติดตามผลด้านการแพทย์และสังคม (2 บริการ) เช่น การเยี่ยมบ้าน, การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต

ลำดับ	ประเภทรายการ	หน่วยนับ	ราคา
1	การตรวจประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคม	ราย	300
2	การประเมินปัญหาทางสังคมและความพร้อมของ ผู้ป่วย ครอบครัว ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล	ราย	350
3	การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งประเมินอายุเด็กทางคดี	กิจกรรม	600
4	การเตรียมความพร้อมเพื่อส่งตรวจ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (DNA) และความสัมพันธ์ทางสายเลือด	กิจกรรม	600
5	การให้การปรึกษารายบุคคล	ราย	350

ลำดับ	ประเภทรายการ	หน่วยนับ	ราคา
6	การให้การปรึกษารายกลุ่ม	ราย	300
7	การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ทางโทรศัพท์/ Online Application	ครั้ง	400
8	การให้คำปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ โดย ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)	ครั้ง	400
9	การให้คำปรึกษาทางเลือก (Option Counseling)	ครั้ง	350
10	การให้คำปรึกษารอบครัว	ครั้ง	350
11	การบำบัดทางสังคม	ครั้ง	300
12	การทำกลุ่มจิตบำบัด (ทั่วไป)	ครั้ง	400
13	กลุ่มบำบัดเฉพาะโรคเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ	กิจกรรม	850
14	การทำครอบครัวบำบัด	ครั้ง	350
15	การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment)	ครั้ง	300
16	ฝึกทักษะทางสังคมรายบุคคล โดยนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	กิจกรรม	600
17	เตรียมทักษะทางสังคมก่อนส่งไปสถานสงเคราะห์	กิจกรรม	350
18	การจัดทำแผนการดูแลทางสังคม ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะท้าย	กิจกรรม	350
19	การจัดการทรัพยากรทางสังคมและพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Social Resources Management and Advocacy)	กิจกรรม	350
20	การเยี่ยมและจัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในโรงพยาบาล	ครั้ง	350
21	จัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	กิจกรรม	1,200
22	การเยี่ยมบ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์	ราย	1,200
23	ติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต และติดตามประเมินปัญหาทางสังคม ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ และการฟื้นฟูสภาพ (Recovery) ผู้ป่วยหลังจำหน่าย	กิจกรรม	350
24	การตรวจประเมินวินิจฉัยปัญหาทางสังคมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	ครั้ง	500
25	ประเมินจิตสังคม ประเมินความพิการ ความบกพร่อง ความสามารถทางสังคม ทักษะทางสังคม	ครั้ง	350
26	การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยที่มีความรุนแรง (SMIV)	ครั้ง	750

ลำดับ	ประเภทรายการ	หน่วยนับ	ราคา
27	การให้การปรึกษาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ครั้ง	550
28	การบำบัดทางสังคมรายบุคคล	ครั้ง	450
29	การบำบัดทางสังคม รายกลุ่ม	ครั้ง	450
30	การสนับสนุนทางสังคม(social Support)	ครั้ง	450
31	ผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)	กิจกรรม	1,400
32	การฝึกทักษะทางสังคม รายบุคคล	ครั้ง	450
33	การฝึกทักษะทางสังคม รายกลุ่ม	ครั้ง	450
34	การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมรายบุคคล	ครั้ง	450
35	การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมรายกลุ่ม	ครั้ง	450
36	เตรียมทักษะสังคมก่อนส่งไปสถานสงเคราะห์/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง (รายบุคคล)	กิจกรรม	450
37	เตรียมทักษะสังคมก่อนส่งไปสถานสงเคราะห์/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง(รายกลุ่ม)	กิจกรรม	350
38	เตรียมความพร้อมด้านสังคม ผู้ป่วย ครอบครัวเครือข่ายและชุมชน	กิจกรรม	450
39	เตรียมความพร้อมก่อนและหลังการประกอบอาชีพ และการมีงานทำ	ครั้ง	750
40	การบำบัดฟื้นฟู จิตสังคมแบบบูรณาการ (Psycho Social Intervention) ผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อน/ ผู้ป่วยยาเสพติด /โรคร่วม	ครั้ง	1,000

3. ตัวอย่างแนวทางในบันทึกรหัสกลุ่มเปราะบางใน PLATFORM SOCIAL TELECARE ระหว่างกลุ่มเปราะบางกับกลุ่มให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ลำดับ	กลุ่มเปราะบาง	เครื่องมือออนไลน์ที่ใช้	การประเมินปัญหาทางสังคม	การปรับแผนบริการทางการแพทย์	เอกสารอ้างอิง
1	ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	- S.D.M.A. (Social Diagnosis and Management Assessment) - WHOQOL-BREF (คุณภาพชีวิต)	ประเมินปัญหาทางสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติ การขาดรายได้	ปรับแผนการรักษาโดยคำนึงถึงปัจจัยทางสังคม เช่น การเข้าถึงยาต้านไวรัส	กรมควบคุมโรค สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	กลุ่ม ประชากร	เครื่องมือ ออนไลน์ที่ใช้	การประเมินปัญหา ทางสังคม	การปรับแผนบริการ ทางการแพทย์	เอกสารอ้างอิง
2	แม่วัยรุ่น/ หญิงตั้งครรภ์ ไม่พึงประสงค์	- F.R.A. (Family Readiness Assessment) - WAST (ความ รุนแรงใน ครอบครัว)	ประเมินความพร้อม ของครอบครัวและ ความเสี่ยงทางสังคม	ปรับบริการฝากครรภ์ และให้คำปรึกษาด้าน สุขภาพจิต	กรมอนามัย สมาคมนัก สังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ ไทย
3	ผู้ป่วยแรงงาน ข้ามชาติ	- S.D.M.A. - แบบประเมิน ปัญหาทางสังคม	ประเมินปัญหาด้าน ภาษา การเข้าถึง บริการสุขภาพ และ สถานะทางกฎหมาย	ปรับบริการสุขภาพให้ สอดคล้องกับ วัฒนธรรมและภาษา ของผู้ป่วย	กรมสุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข
4	ผู้ป่วย ต่างชาติ	- S.D.M.A. - WHOQOL- BREF	ประเมินปัญหาด้าน ภาษาและวัฒนธรรม	ปรับบริการสุขภาพให้ สอดคล้องกับ วัฒนธรรมและภาษา ของผู้ป่วย	กรมสุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข
5	ผู้ป่วย คนพิการ	- ICF (International Classification of Functioning) - S.S.A. (Social Skill Assessment)	ประเมินความ สามารถทางสังคม และทักษะการปรับตัว	ปรับบริการฟื้นฟู สมรรถภาพและให้คำ ปรึกษาด้านอาชีพ	กรมการแพทย์ องค์การอนามัย โลก (WHO), กรม สุขภาพจิต
6	ผู้ป่วย ถูกระทำ ทารุณกรรม	- WAST (ความ รุนแรงใน ครอบครัว) - CMST (Child Maltreatment Surveillance Tool)	ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบทางจิต สังคม	ปรับบริการสุขภาพจิต และให้ความช่วยเหลือ ด้านกฎหมาย	กองบริหารการ สาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข
7	ผู้มีปัญหาการ ติดยาและสาร เสพติด	- DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) - AUDIT (สุรา)	ประเมินปัญหาการ ติดยาและสารเสพติด	ปรับแผนการรักษา โดยรวมการบำบัดทาง สังคมและสุขภาพจิต	สถาบันบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราช ชนนี (สบยช)
8	ผู้ป่วยไร้บ้าน	- S.D.M.A. - WHOQOL- BREF	ประเมินปัญหาด้านที่ อยู่อาศัยและรายได้	ปรับบริการสุขภาพโดย คำนึงถึงสภาพความ เป็นอยู่และความเสี่ยง ทางสังคม	สมาคมนัก สังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ ไทย
9	ผู้ป่วยต้องขัง/ สถานพินิจ	- S.D.M.A. - แบบประเมิน ปัญหาทางสังคม	ประเมินปัญหาด้าน สุขภาพจิตและสังคม	ปรับบริการสุขภาพจิต และให้คำปรึกษาด้าน อาชีพหลังพ้นโทษ	กองการบริหาร สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข

ลำดับ	กลุ่ม เป้าหมาย	เครื่องมือ ออนไลน์ที่ใช้	การประเมินปัญหา ทางสังคม	การปรับแผนบริการ ทางการแพทย์	เอกสารอ้างอิง
10	ผู้ป่วยสูงอายุ	- Barthel ADL (กิจวัตรประจำ วัน) - WHOQOL- BREF	ประเมินความสามารถ ในการดูแลตนเองและ คุณภาพชีวิต	ปรับบริการสุขภาพให้ สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้สูงอายุ	กรมอนามัย, กรม สุขภาพจิต
11	ผู้ป่วยวัณโรค	- S.D.M.A. - WHOQOL- BREF	ประเมินปัญหาด้าน การเข้าถึงการรักษา และความเสี่ยงทาง สังคม	ปรับแผนการรักษา โดยคำนึงถึงปัจจัย ทางสังคม เช่น การ เข้าถึงยา	กรมควบคุมโรค, กรมสุขภาพจิต
12	ผู้ป่วยระยะ ประคับ ประคองและ ระยะท้าย	- PPS (Palliative Performance Score) - Advance Care Plan	ประเมินความต้องการ ด้านการดูแลระยะ ท้าย	ปรับบริการดูแลประ คับประคองโดยคำนึง ถึงความต้องการของ ผู้ป่วยและครอบครัว	กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต
13	ผู้ป่วยโรค โควิด-19/โรค อุบัติใหม่	- แบบประเมิน สุขภาพหลังโค วิด-19 - WHOQOL- BREF	ประเมินผลกระทบ ทางสังคมและสุขภาพ หลังติดเชื้อ	ปรับบริการสุขภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบ ระยะยาวจากโค วิด-19	กระทรวง สาธารณสุข
14	ผู้ป่วยจิตเวช	- PHQ-9 (โรคซึม เศร้า) - S.S.A.	ประเมินปัญหาด้าน สุขภาพจิตและทักษะ ทางสังคม	ปรับบริการสุขภาพ จิตโดยรวมการบำบัด ทางสังคมและทักษะ การปรับตัว	กรมสุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข
15	ผู้ป่วย โรคเรื้อรัง	- S.D.M.A. - WHOQOL- BREF	ประเมินปัญหาด้าน การจัดการโรคและ คุณภาพชีวิต	ปรับแผนการรักษา โดยคำนึงถึงปัจจัย ทางสังคม เช่น การ เข้าถึงยาและบริการ สุขภาพ	สำนักปลัด กระทรวง สาธารณสุข สมาคมนัก สังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ ไทย
16	ผู้ป่วยไร้ สถานะทาง กฎหมาย	- S.D.M.A. - แบบประเมิน ปัญหาทางสังคม	ประเมินปัญหาด้าน สถานะทางกฎหมาย และการเข้าถึงบริการ สุขภาพ	ปรับบริการสุขภาพให้ สอดคล้องกับสถานะ ทางกฎหมายและ ความต้องการของผู้ ป่วย	สำนักงานหลัก ประกันสุขภาพ แห่งชาติ กองการ บริหาร สาธารณสุขกรม สุขภาพจิต, กระทรวง สาธารณสุข
17	ผู้ป่วยถูกทอด ทิ้ง	- S.D.M.A. - WHOQOL- BREF	ประเมินปัญหาด้าน การขาดการสนับสนุน ทางสังคม	ปรับบริการสุขภาพ โดยคำนึงถึง ความต้องการด้านการ สนับสนุนทางสังคม	สมาคมนัก สังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์ ไทย
18	ผู้ป่วยโรค มะเร็ง	- PPS (Palliative Performance Score) - WHOQOL- BREF	ประเมินความต้องการ ด้านการดูแลและ คุณภาพชีวิต	ปรับบริการดูแลประ คับประคองและให้คำ ปรึกษาด้านสุขภาพ จิต	กรมการแพทย์, กรมสุขภาพจิต

4. ตัวอย่างแนวทางการออกแบบบริการและบันทึกรหัสในกลุ่มเปราะบางที่พบบ่อย

ผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ :
การวินิจฉัยทางสังคม	• การให้คำปรึกษาทางสังคม • การจัดการทรัพยากรทางสังคม • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ, การขาดการสนับสนุนทางสังคม, ปัญหาทางเศรษฐกิจ	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง :	
• Z20.6 (Contact with and exposure to HIV) • Z59.5 (Extreme poverty) • Z60.5 (Social exclusion and rejection)	
แม่วัยรุ่น/หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์:
การวินิจฉัยทางสังคม	• การให้คำปรึกษาครอบครัว • การเตรียมความพร้อมด้านสังคม • การเยี่ยมบ้าน * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง, การขาดการสนับสนุนจากครอบครัว, ปัญหาทางเศรษฐกิจ	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	
• Z64.0 (Problems related to unwanted pregnancy) • Z62.0 (Inadequate parental supervision and control) • Z59.6 (Low income)	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	• การฝึกทักษะทางสังคม • การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การวินิจฉัยทางสังคม	
การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำกัด, การถูกเอารัดเอาเปรียบ, ปัญหาการสื่อสาร	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง :	
• Z59.7 (Insufficient social insurance and welfare support) • Z60.3 (Acculturation difficulty) • Z56.0 (Unemployment, unspecified)	
ผู้ป่วยคนพิการ	บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์:
ปัญหาซับซ้อน :	• การฝึกทักษะทางสังคม • การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การเข้าถึงบริการสุขภาพที่ยากลำบาก, การขาดการสนับสนุนทางสังคม, ปัญหาทางเศรษฐกิจ	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	

• Z73.6 (Limitation of activities due to disability) • Z59.5 (Extreme poverty) • Z60.4 (Social exclusion and rejection)	
ผู้ป่วยถูกระงับการทารุณกรรม	บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์:
การวินิจฉัยทางสังคม	• การให้คำปรึกษาทางสังคม • การบำบัดทางสังคม • การเยี่ยมบ้าน * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความเครียดทางจิตใจ, การขาดความปลอดภัย, ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	
• Z61.4 (Problems related to alleged sexual abuse of child) • Z61.6 (Problems related to alleged physical abuse of child) • Z63.0 (Problems in relationship with spouse or partner)	
ผู้มีปัญหาการติดยาและสารเสพติด	บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์:
การวินิจฉัยทางสังคม	• การให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด • การบำบัดฟื้นฟูจิตใจสังคม • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การขาดการสนับสนุนทางสังคม, ปัญหาทางเศรษฐกิจ, ความเสี่ยงต่อการกลับมาเสพติด	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง :	
• Z72.2 (Drug use) • Z59.6 (Low income) • Z63.7 (Other stressful life events affecting family and household)	
ผู้ป่วยไร้บ้าน	บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ :
การวินิจฉัยทางสังคม	• การจัดการทรัพยากรทางสังคม • การเยี่ยมบ้าน • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การขาดที่อยู่อาศัย, การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำกัด, ปัญหาทางเศรษฐกิจ	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	
• Z59.0 (Homelessness) • Z59.5 (Extreme poverty) • Z60.4 (Social exclusion and rejection)	

ผู้ป่วยต้องขัง/สถานพินิจฯ	บริการสังคมสงเคราะห์ ทางกายภาพ : • การให้คำปรึกษาทางสังคม • การบำบัดทางสังคม • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การวินิจฉัยทางสังคม	
การขาดการสนับสนุนทางสังคม, ปัญหาทางเศรษฐกิจ, ความเสี่ยงต่อการกลับมามีปัญหาซ้ำ	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	
• Z65.1 (Imprisonment and other incarceration) • Z59.6 (Low income) • Z60.4 (Social exclusion and rejection)	
ผู้ป่วยสูงอายุ	บริการสังคมสงเคราะห์ ทางกายภาพ : • การเยี่ยมและจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ • การจัดบริการทางการแพทย์ทางสังคม • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การวินิจฉัยทางสังคม	
การขาดการสนับสนุนทางสังคม, ปัญหาทางเศรษฐกิจ, การเข้าถึงบริการสุขภาพที่ยากลำบาก	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง:	
• Z73.6 (Limitation of activities due to disability) • Z59.5 (Extreme poverty) • Z63.2 (Inadequate family support)	
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง)	บริการสังคมสงเคราะห์ ทางกายภาพ : • การให้คำปรึกษาทางสังคม • การจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง • การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต * หรือบริการอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
การวินิจฉัยทางสังคม	
การขาดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง, ปัญหาทางเศรษฐกิจ, การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำกัด	
ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง :	
• Z73.6 (Limitation of activities due to disability) • Z59.6 (Low income) • Z63.2 (Inadequate family support)	

ตัวอย่าง กลุ่มควบคุมโรคได้ไม่ดี ส่งกระทบทุกมิติกายจิตสังคม

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา การวินิจฉัยทางสังคม พร้อมรหัส ICD10 ที่เกี่ยวข้อง

วัณโรคดื้อยา (MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS : MDR -TB และ EXTENSIVELY DRUG - RESISTANT TUBERCULOSIS : XDR - TB) ถือเป็นหนึ่งในปัญหาท้าทายของระบบสาธารณสุขเนื่องจากต้องใช้การวินิจฉัยที่แม่นยำ การรักษาต่อเนื่องนานหลายเดือน และการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด แต่เมื่อระบบควบคุมโรคมีประสิทธิภาพต่ำ จะส่งผลกระทบใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1) มิติกายภาพ (PHYSICAL) โรคดำเนินรุนแรง เสี่ยงแพร่เชื้อสูง 2) มิติด้านจิตใจ (PSYCHOLOGICAL) ซึมเศร้า หดท้อ กังวล ขาดแรงจูงใจ 3) มิติสังคม (SOCIAL) ถูกตีตรา ขาดการสนับสนุน ขาดรายได้/การเข้าถึงบริการ

ตารางแสดง รายการสาเหตุที่ทำให้การควบคุมวัณโรคดื้อยาไม่มีประสิทธิภาพพร้อมผลกระทบ และรหัส ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	สาเหตุ/ปัญหา	การวินิจฉัย	ICD-10 ที่เกี่ยวข้อง
1	ขาดระบบรายงานและติดตามผู้ป่วยหลังเริ่มรักษา	ขาดนัด หยุดยาเอง	Z91.1 – Noncompliance with medical treatment
2	ไม่มีระบบตรวจวินิจฉัยดื้อยา (DST, GeneXpert) อย่างครอบคลุม	เริ่มรักษาช้า ไม่ตรงยาชนิดดี	U84.3 – Drug-resistant tuberculosis
3	ยาต้านวัณโรคไม่ครบหรือขาดเวชภัณฑ์	รักษาไม่หาย เสี่ยงแพร่เชื้อ	Z59.7 – Inadequate drug supply
4	ไม่มีระบบติดตามแบบ DOT (Directly Observed Therapy)	ผู้ป่วยลืม หรือหลีกเลี่ยงการกินยา	Z75.3 – Health service inaccessibility
5	บุคลากรสาธารณสุขไม่พอ หรือไม่มีการติดตามถึงบ้าน	ไม่ได้รับการนิเทศ หรือการดูแลต่อเนื่อง	Z76.3 – Encounter health services
6	ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว	ไม่เข้าใจโรค / หลงเชื่อข้อมูลผิด	Z55.8 – Inadequate health literacy
7	ความยากจนและขาดแคลนค่าเดินทาง/อาหารระหว่างรักษา	ขาดยา / ล้มเลิกการรักษา	Z59.5 – Extreme poverty
8	ผู้ป่วยรู้สึกถูกตีตราในชุมชน (Stigma)	ซ่อนอาการ หลีกเลี่ยง รักษาช้า	Z60.5 – Discrimination
9	ภาวะซึมเศร้าหรือหมดกำลังใจจากโรคเรื้อรัง	ขาดแรงจูงใจ / เสี่ยงฆ่าตัวตาย	F32.9 – Depressive episode
10	การส่งต่อระหว่างรพ.และสาธารณสุขตำบลไม่มีประสิทธิภาพ	ขาดตอนการดูแล – เสี่ยงหลุดระบบ	Z75.8 – Problems related to care system

ผลกระทบต่อมิติกาย-จิต-สังคม

ผลกระทบของวัณโรคดื้อยา (MDR/XDR-TB) ต่อมิติกาย-จิต-สังคม จากการควบคุมโรคที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลกระทบเชื่อมโยงกันในแต่ละมิติ สรุปดังนี้

มิติกายภาพ (BODY DIMENSION)

ผลกระทบ :

1. วัณโรครุนแรงขึ้น

- เมื่อการวินิจฉัยและเริ่มรักษาล่าช้า หรือไม่เหมาะสมกับเชื้อที่ดื้อยา ผู้ป่วยจะมีการดำเนินของโรคที่รุนแรงขึ้น เช่น เกิดโพรงในปอด เลือดออกจากทางเดินหายใจ หรือการแพร่เชื้อสูงมาก
- เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เช่น วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง วัณโรคกระดูก
- ICD-10 : A15.0 / U84.3

2. ติดเชื้อซ้ำ/แพร่เชื้อให้ผู้อื่นในครอบครัวหรือชุมชน

- โดยเฉพาะหากผู้ป่วยไม่แยกตัวหรือรักษาไม่ครบ
- ส่งผลให้วงจรวัณโรคในชุมชนขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

3. ยืดระยะเวลาการรักษา / ต้องใช้ยาแรงขึ้น

- จากเดิม 6 เดือน อาจยาวนานถึง 18–24 เดือน
- ยาอาจมีผลข้างเคียงรุนแรง เช่น หูหนวก ไตวาย ตับอักเสบ
- ทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมาก

มิติด้านจิตใจ (MIND DIMENSION)

ผลกระทบ :

1. ภาวะซึมเศร้าและหมดกำลังใจ

- ผู้ป่วยหลายรายรู้สึก "เหนื่อย" จากการรักษายาวนาน
- เมื่อผลข้างเคียงของยาแรงเกิดขึ้น (เช่น คลื่นไส้ หูหนวก) ก็ยิ่งรู้สึกสิ้นหวัง
- ICD-10 : F32.9 – DEPRESSIVE EPISODE

2. รู้สึกถูกตีตราและแยกตัวจากสังคม (STIGMA)

- ทั้งในครอบครัว ที่ทำงาน และชุมชน
เช่น ถูกบอกให้ย้ายออกจากบ้าน ถูกห้ามจับของร่วม หรือถูกกีดกัน
- ทำให้ไม่กล้าเข้ารับบริการ เสี่ยงแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัว
- ICD-10 : Z60.5 – PERCEIVED ADVERSE DISCRIMINATION

3. ความวิตกกังวลเรื้อรังและเสี่ยงฆ่าตัวตาย

- พบในกลุ่มที่รู้ว่าเป็น XDR-TB หรือมีผลข้างเคียงรุนแรง
- หากไม่มีระบบสนับสนุนทางจิตใจที่เพียงพอ อาจเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
- ICD-10 : R45.8 – OTHER SYMPTOMS AND SIGNS INVOLVING EMOTIONAL STATE

มิติสังคม (SOCIAL DIMENSION)

ผลกระทบ :

1. ว่างาน/ขาดรายได้จากการต้องหยุดงานระยะยาว

- วัณโรคดื้อยาต้องหยุดงานอย่างน้อย 6–24 เดือน
- แรงงานนอกระบบหรือรับจ้างจะไม่มีรายได้ใด ๆ รองรับ
- ICD-10 : Z59.5 – EXTREME POVERTY

2. ถูกปฏิเสธจากครอบครัวหรือชุมชน

- บางรายถูกห้ามกลับบ้าน ถูกแยกกักโดยไม่มีการดูแล
- เด็กหรือหญิงมีครรภ์ยังมีความเสี่ยงต่อการโดดเดี่ยวสูง
- ICD-10: Z63.5 – DISRUPTION OF FAMILY BY SEPARATION

3. ขาดการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

- เช่น อยู่ห่างจาก รพ./ไม่มีพาหนะ/ไม่มีเงินค่าเดินทาง
- หรือขาดความรู้ในการรับบริการ (HEALTH LITERACY ต่ำ)
- ICD-10 : Z75.3 – INACCESSIBILITY OF HEALTH-CARE FACILITIES

แนวทางการปฏิบัติ

● บูรณาการ **แนวทางเวชปฏิบัติ (NTP), สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, สุขภาพจิต และการเยี่ยมบ้าน** เข้าด้วยกัน

● **SOCIAL WORK CASE CONFERENCE** : ระดมทีม (แพทย์, พยาบาล, นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, อสม.) ถกปัญหาผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

● **ใช้เครื่องมือแบบประเมิน SMDA ,FRA และปัจจัย Z-CODES ICD 10** เพื่อเข้าใจสถานะชีวิตรอบด้านของผู้ป่วย

● **เยี่ยมบ้านและพูดคุยกับครอบครัว** เพื่อสร้างพันธมิตรในการดูแล ไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยลำพัง

● **PEER SUPPORT PROGRAM** : ผู้ป่วยหายแล้วช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ป่วยรายใหม่

● **ระบบติดตาม (TRACKING + TELECARE)** ที่ให้ผู้ป่วยรู้ว่า “คุณไม่ได้เดินคนเดียว” เน้น **การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง(WHOLE PERSON-CENTERED CARE)** ที่เข้าใจบริบทชีวิตผู้ป่วย

แนวคิด **การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง** เป็นกรอบแนวคิดสำคัญที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น **วัณโรคดื้อยา (MDR/XDR-TB)** เพราะครอบคลุม **มิติทางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ** โดยมีเป้าหมายหลักคือการ **เข้าใจชีวิตผู้ป่วยในบริบทจริง** ไม่ใช่แค่การจ่ายยาให้หายโรค **การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สำคัญกับวัณโรคดื้อยา**

เพราะผู้ป่วยไม่ได้ต้องการแค่ "ยา" แต่ต้องการ :

- ความเข้าใจจากทีมดูแลว่า "ทำไมเขาถึงขาดนัด?"
- การรับฟังว่า "สิ่งใดที่ทำให้เขาไม่อยากกินยา?"
- ความมั่นใจว่าถ้ารักษาแล้ว "ชีวิตเขาจะดีขึ้นจริง"

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาลายคนเผชิญ :

- ความยากจน, การตีตรา, การตกงาน, ปัญหาครอบครัว, ความรู้สึกโดดเดี่ยว
- หากเรามองเห็นแค่ "เชื้อ" แต่ไม่มอง "ชีวิต" การรักษาจะล้มเหลวแม้จะมียาที่ดีที่สุด

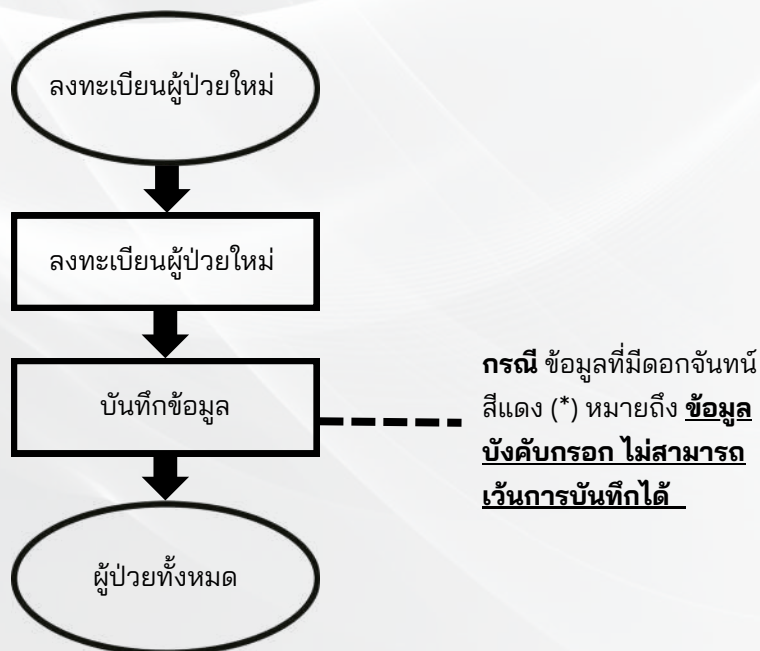
ตารางแสดงแนวทางปฏิบัติตามแนวคิด การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (โดยเฉพาะกับวัณโรคดื้อยา)

มิติ	แนวทางปฏิบัติ	ตัวอย่าง
กายภาพ (Body)	วินิจฉัยรวดเร็ว ใช้ยาที่เหมาะสมกับเชื้อ และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง	ใช้ GeneXpert, Line probe assay, DOT ผ่าน Telecare
จิตใจ (Mind)	คัดกรองภาวะซึมเศร้า/วิตกกังวล และให้การสนับสนุนทางจิตใจ	ให้คำปรึกษา ทำกลุ่มผู้ป่วย/peer support
สังคม (Social)	ประเมินบริบทชีวิต (บ้าน ที่อยู่ รายได้ ครอบครัว) และให้การสนับสนุน	เยี่ยมบ้าน, สนับสนุนค่าเดินทาง/อาหาร
สิ่งแวดล้อม (Environment)	ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการรักษา	จัดแยกพื้นที่อยู่/พักฟื้น ปรับที่อยู่อาศัยให้อากาศถ่ายเท
จิตวิญญาณ (Spirituality)	รับฟังความเชื่อ ศรัทธา หรือแรงบันดาลใจของผู้ป่วย	ให้โอกาสแสดงออกด้านศาสนา การเยียวยาทางใจ

กล่าวโดยสรุป การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (WHOLE PERSON-CENTERED CARE) คือ การดูแลรักษาที่ : “ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เข้าใจความต้องการ ความเชื่อ และบริบทชีวิตของเขาอย่างแท้จริง” ไม่ใช่เพียง “รักษาโรค” แต่ต้อง “ดูแลคนที่มีโรคอยู่ในชีวิตของเขา”

กลุ่มเปราะบาง มีปัญหาซับซ้อนที่ต้องการการวินิจฉัยทางสังคมและการสนับสนุนจากบริการสังคม สงเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครอบคลุม โดยการใช้ ICD - 10 ในการระบุปัญหาทางสังคมและการเชื่อมโยงกับบริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 5 ระบบ 40 บริการ จะช่วยให้ทีมสหวิชาชีพสามารถวางแผนการดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. รายละเอียดและวิธีการ (PROCESS) การนำเข้าข้อมูลผู้ป่วย



5.1 การรวบรวมข้อมูล (INTAKE)

5.1.1. นักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการลงทะเบียนในเมนูลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

5.1.2. นักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำการบันทึกข้อมูล กรณี ข้อมูลที่มีดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ข้อมูลบังคับกรอกไม่สามารถเว้นการบันทึกได้

5.1.3. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะนำคุณเข้ามาสู่หน้าการประเมินผู้ป่วยในความดูแลโดยอัตโนมัติ

Social Telecare
แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบาง

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

สามารถค้นหาชื่อ รหัส ผ่านช่อง Search กดเลือกเพื่อดูบริการในตารางได้เลย

Show Search: 10678

รหัส	ชื่อหน่วยบริการ	จังหวัด	เขตพื้นที่สุขภาพ	ประเภทสถานพยาบาล	ระดับ
10678	รพ.เจ้าพระยาบวรราช	สุพรรณบุรี	เขต 5 ราชบุรี	โรงพยาบาลศูนย์	ระดับศูนย์

Showing 1 to 1 of 1 records (filtered from 12,034 total entries)

รหัสสถานพยาบาล * 10678 ชื่อหน่วยบริการ รพ.เจ้าพระยาบวรราช จังหวัด สุพรรณบุรี

Social Telecare
แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบาง

นาย คบ สัน ครัว
นักสังคมสงเคราะห์ (ผู้ใช้งาน)

ข้อมูลแบบกราฟภาพรวม
ประกาศ
จัดการผู้ป่วยทั้งหมด
บันทึกรายงานการให้บริการ
จัดการผู้สมัครสมาชิก

นาย คบ สัน ครัว
รหัสประจำตัวประชาชน: 3848923649370
รายงานผลการนำบริการสังคม - V2
ยังไม่ระบุ

1. ข้อมูลทั่วไป 2. เครื่องมือการประเมิน 3. ลงทะเบียนและประเมินผล 4. ติดตามและประเมินผล

ข้อมูลผู้ป่วย

ประเภทสถานพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์
รหัสสถานพยาบาล 10678

ส่งต่อผู้ป่วย ยกเลิกข้อมูล

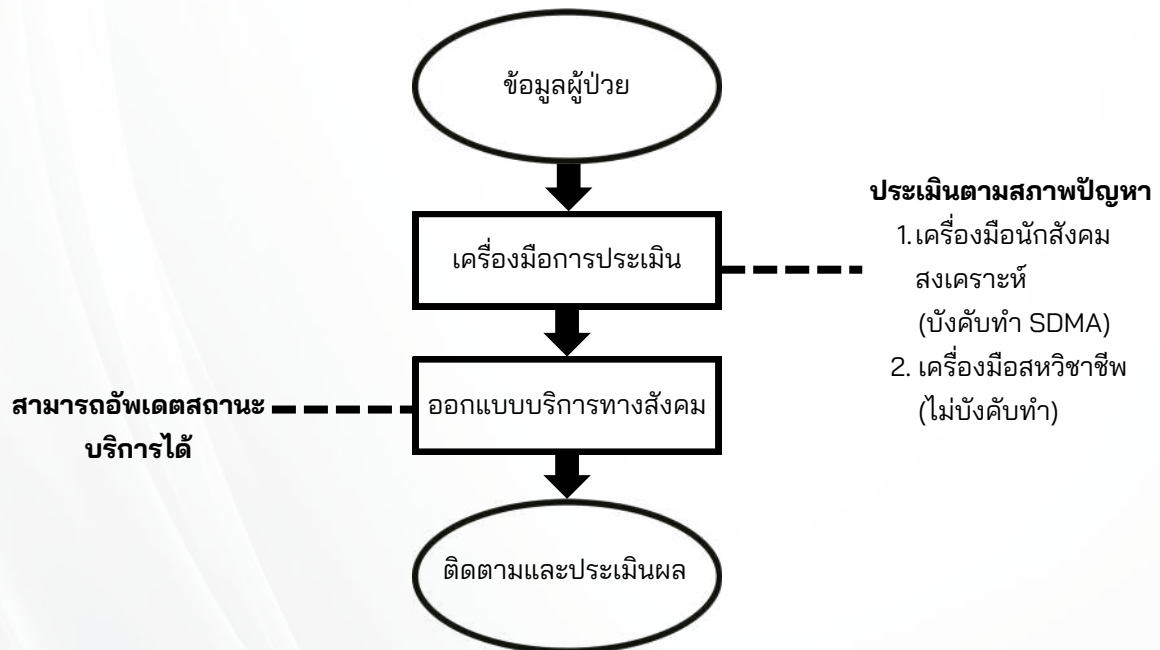
5.1.4. หากกรณีบันทึกไม่สำเร็จ ระบบจะแสดง POP UP แจ้งเตือน ให้คุณกลับไปดูข้อมูลที่ยังไม่ได้ลงบันทึก



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตกลง

5.2 การออกแบบและวางแผนบริการ (DESIGN & PLANNING)



- ใช้ผลการวิเคราะห์ในการกำหนดแผนดูแลเฉพาะบุคคล (INDIVIDUAL CARE PLAN) ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละผู้ป่วย

- ออกแบบรูปแบบบริการที่ครอบคลุมทั้งการบำบัดทางจิตใจ การสนับสนุนด้านสิทธิและสวัสดิการ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หน้าต่างจะแสดงผลระยะดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอน

ขั้นตอน		นิยาม
1	ข้อมูลทั่วไป	ข้อมูลทั่วไปที่มาจาก การลงทะเบียนผู้ป่วย
2	เครื่องมือการประเมิน	แบบประเมินวินิจฉัยและวางแผนทางสังคม รวมถึงแบบประเมินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้ป่วย
3	ออกแบบแผนและจัดบริการทางสังคม	การออกแบบบริการทางสังคม การจัดการสถานะการให้บริการทางสังคม โดยแบ่งเป็น กำลังดำเนินการ และ ดำเนินการแล้ว โดยทั้งนี้ นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ทำการประเมินสามารถ ใช้ปุ่มกำลังดำเนินการทั้งหมด และ ดำเนินการแล้วทั้งหมด ได้
4	ติดตามและประเมินผล	การติดตามผลตามแบบประเมินตามเครื่องมือต่าง ๆ ที่ท่านได้ประเมิน

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผ่าน SOCIAL TELECARE

บทที่ 4

1. ความหมายของแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม หมายถึง การใช้กระบวนการเชิงระบบ และหลักวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาแผนการดูแลและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบหลัก

2.1 การรวบรวมข้อมูล (INTAKE & FACT FINDING)

การสัมภาษณ์ สํารวจ และใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประวัติผู้ป่วย สภาพแวดล้อม และปัญหาที่พบ

2.2 การประเมินและวินิจฉัย (ASSESSMENT & DIAGNOSIS)

ใช้เครื่องมือมาตรฐาน เช่น แบบประเมินสุขภาพจิต และ PALLIATIVE PERFORMANCE SCORE เพื่อประเมินความต้องการและระดับความเสี่ยง

2.3 การวางแผนและออกแบบบริการ (PLANNING & DESIGN)

จัดทำแผนการดูแลเฉพาะบุคคล (INDIVIDUAL CARE PLAN) ที่ครอบคลุมทุกมิติของการดูแล

2.4 การดำเนินงานและแทรกแซง (INTERVENTION)

ใช้เทคโนโลยี SOCIAL TELECARE เพื่อให้บริการ เช่น TELETHERAPY และ FAMILY COUNSELING

2.5 การติดตามและประเมินผล (MONITORING & EVALUATION)

ติดตามความคืบหน้า ประเมินผลลัพธ์ และรับข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงบริการ



3. วิธีการที่ประเมินสามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม

วิธีการที่ช่วยให้ผู้ประเมินสามารถระบุและวิเคราะห์ปัญหาหลายด้านในชีวิตของบุคคลได้ในเวลาเดียวกัน โดยใช้รหัสที่อิงตามมาตรฐาน ICF ของ WHO ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางสังคม

หลักการของแบบบัญชีปัญหาทางสังคม

● **การระบุหลายปัญหา :** แบบนี้สามารถระบุได้มากกว่า 1 ปัญหาต่อคน เพราะในชีวิตจริง บุคคลอาจเผชิญกับปัญหาหลากหลายด้าน เช่น ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาทางการเงิน หรือปัญหาด้านการดูแลสุขภาพ

● **มาตรฐาน ICF ของ WHO :** ใช้รหัสเฉพาะ (เช่น D770 สำหรับปัญหาคู่สมรส, D760 สำหรับปัญหาระหว่างบิดา มารดา บุตร) เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเปรียบเทียบได้ง่าย

4.

การตรวจประเมินวินิจัยปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

คำนิยาม

การตรวจประเมินวินิจัยปัญหาทางสังคม ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ : นักสังเคราะห์ศึกษาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลประวัติบุคคล ประวัติครอบครัว สิ่งแวดล้อม ชุมชน ใช้หลักการวินิจัยทางสังคมตามแบบบัญชีปัญหาทางสังคม (SOCIAL PROBLEM LIST) เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการและนำไปวางแผนการจัดบริการทั้งระยะเฉพาะหน้าและระยะยาวเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

ศึกษารวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาวะทางสังคม พัฒนาการของบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัว แบบแผนการดำเนินชีวิต ความสามารถในการดำรงชีวิต ในทางสังคมและสภาวะแวดล้อม เช่น อาชีพ การงาน การศึกษา การทำกิจวัตรประจำวัน การทำงานบ้าน การเข้าสังคม รูปแบบการเผชิญปัญหา อุปสรรค และการปรับตัวทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพของผู้ป่วยและครอบครัว เครือข่ายทางสังคมของบุคคล แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติ และ ปัญหาปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหาในอดีตและความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ การณ์ของปัญหา เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย สาเหตุปัญหาหรือปัจจัยทางสังคมอื่น ที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพอนามัย ผลกระทบจากปัญหาที่ส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อประกอบการวางแผนให้การบำบัดช่วยเหลือทางสังคม

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่

1. ผู้ป่วยเอดส์/ผู้มีเชื้อเอชไอวี
2. แม่วัยรุ่น/หญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
3. ผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ (ลาว เมียนมา กัมพูชาและเวียดนาม)
4. ผู้ป่วยต่างชาติ
5. ผู้ป่วยคนพิการ
6. ผู้ป่วยถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (OSCC)
7. ผู้มีปัญหาการติดยาและสารเสพติด
8. ผู้ป่วยไร้บ้าน
9. ผู้ป่วยต้องขัง / สถานพินิจฯ / ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / สถานกักกันและสถาน

ดูแลของรัฐ

10. ผู้ป่วยสูงอายุ
11. ผู้ป่วยวัณโรค
12. ผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะท้าย
13. ผู้ป่วยโรค โควิด – 19/โรคอุบัติใหม่
14. ผู้ป่วยจิตเวช
15. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
16. ผู้ป่วยไร้สถานะทางกฎหมาย
17. ผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง
18. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม
1. เตรียมผู้ป่วยและญาติ	เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้ ● สร้างสัมพันธภาพ ● อธิบายขั้นตอนการรักษา ● ทำความเข้าใจกับความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ
2. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย	รวบรวมข้อมูล ผู้ป่วยและครอบครัว หาข้อเท็จจริง ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางสังคมของผู้ใช้บริการ โดยการสอบถาม ชักประวัติ
3. ศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม	ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม ประเมินความเสี่ยง และความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว โดยใช้เครื่องมือและแนวทางที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ 1. การประเมินความเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ● ด้านร่างกาย : ประเมินการบาดเจ็บและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ● ด้านจิตใจ : ใช้แบบทดสอบความเครียด (Stress Test) เพื่อวิเคราะห์ภาวะทางจิตใจ ● ด้านสังคม : ประเมินระดับความทุกข์ ความรุนแรงของปัญหา และความพร้อมของผู้ดูแล 2. การประเมินองค์ประกอบส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม ● ใช้การสัมภาษณ์ทางคลินิกและการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสังคม 3. การประเมินความพร้อมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย ● วิเคราะห์ความสามารถของครอบครัวในการดูแล และการให้การปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ ● ใช้เครื่องมือประเมินที่ผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 4. การประเมินทักษะพื้นฐานในการทำงานและการปรับตัวทางสังคม 5. การประเมินปัญหาทางสังคมของผู้ป่วย 6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง ● วิเคราะห์ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์ของผู้ป่วยเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
4. วินิจฉัยปัญหา	วินิจฉัยปัญหาทางสังคม คัดกรองระดับความรุนแรง วินิจฉัยสาเหตุ โดยใช้มาตรฐานการวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง 1. การคัดกรองและประเมินความรุนแรงของปัญหา ● วิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่อาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย ● พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบต่อผู้ป่วยและครอบครัว ● จัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อวางแผนแก้ไขอย่างถูกต้อง 2. การวินิจฉัยทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ● ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ประวัติบุคคล ครอบครัว สิ่งแวดล้อม และชุมชน ● ใช้แนวทางการวินิจฉัยตามมาตรฐาน Social Problem List, ICF และ ICD-10 ของ WHO ● วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือ 3. การบันทึกและรายงานข้อมูล ● สรุปปัญหาทางสังคมที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย ● บันทึกข้อมูลตามแบบรายงานสังคมสงเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติ (ต่อ)

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม
5. การวางแผนช่วยเหลือ	5.1 วางแผนการบำบัดและช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ตามสภาพปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 5.2 กำหนดแนวทางการดูแลทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว 5.3 ประเมินความเสี่ยงและวางแผนป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ใช้เวลาครั้งละ 45 นาที
 2. ในกรณีเยี่ยมบ้าน ใช้เวลาครั้งละ 180 นาที

อ้างอิง : กองโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข หนังสือมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปี พ.ศ. 2542

5. การประเมินปัญหาทางสังคมและความพร้อมของ ผู้ป่วย ครอบครัว ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

คำนิยาม

การประเมินปัญหาทางสังคมและความพร้อมของ ผู้ป่วย ครอบครัว ก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยกระบวนการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ ให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มีความเข้าใจ ยอมรับในการดูแลผู้ป่วยหลังจำหน่าย รายบุคคล รายกลุ่ม ชุมชน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม
1. เตรียมผู้ป่วยและญาติ	การเตรียมผู้ป่วยและครอบครัว ● ใช้เทคนิคสร้างสัมพันธภาพ อธิบายกระบวนการรักษา ● ทำความเข้าใจกับความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติ
2. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย	● แหล่งข้อมูล : เอกสารทางการแพทย์ การสัมภาษณ์ผู้ป่วย ครอบครัว ทีมสหวิชาชีพ ● กระบวนการ : สืบค้นข้อมูล สังเกตพฤติกรรม และเยี่ยมบ้าน
3. ศึกษา ประเมินและวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม	● ด้านร่างกาย : ประเมินการบาดเจ็บและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ป่วย ครอบครัว ● ด้านจิตใจ : ใช้ Stress Test ในการวิเคราะห์ระดับความเครียด ● ด้านสังคม : ประเมินปัญหาทางสังคม และความพร้อมของครอบครัวในการดูแล ● องค์ประกอบส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม: ใช้เครื่องมือวินิจฉัยที่ได้รับการรับรอง เช่น Social Problem List, ICF และ ICD-10 ของ WHO
4. วินิจฉัยปัญหา	การวินิจฉัยปัญหาและแจ้งทีมรักษา ● สรุปสถานะทางสังคมและผลกระทบที่อาจมีต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วย ● กำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดูแล
5. กำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย	การกำหนดแนวทางช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์ ● จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและกำหนดแผนการดูแล ● เตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

หมายเหตุ : ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ใช้เวลาครั้งละ 45 นาที

6. ประเมินจิตสังคม ประเมินความพิการ ความบกพร่อง ความสามารถทางสังคม ทักษะทางสังคม

คำนิยาม

เป็นการประเมินผู้ป่วย เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ นำไปวางแผนการจัดบริการ ประกอบการวางแผนการรักษา บำบัด ฟื้นฟู และการติดตามความสามารถทางสังคม ทักษะทางสังคม โดยใช้เครื่องมือ ทางสังคมสงเคราะห์และเครื่องมือสหวิชาชีพ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม
1. เตรียมผู้ป่วยและญาติ	ใช้เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอธิบายขั้นตอนการรักษา ทำความเข้าใจกับความคาดหวังของผู้ป่วยและ ญาติในการรักษา
2. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย	รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยจากเอกสารและบุคคล โดยการสืบค้นข้อมูล สัมภาษณ์ สังเกต พฤติกรรมของผู้ป่วย ข้อมูลของครอบครัว และความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว จากผู้ป่วย ญาติ และทีมสหวิชาชีพ รวมถึงการสัมภาษณ์ทางวิชาชีพ การเยี่ยมบ้าน และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม	1) ประเมินสมรรถนะผู้ป่วย ความบกพร่อง ข้อจำกัดบางอย่างรวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2) ประเมินปัจจัยแวดล้อม 2.1 ปัจจัยด้านแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สังคม และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับ บุคคล อิทธิพลในแง่บวกหรือแง่ลบ ต่อบุคคล 2.2 สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น บ้าน ที่ทำงาน และโรงเรียน ครอบครัว คนรู้จัก เพื่อน และคนแปลกหน้า 2.3 ระบบสังคม – โครงสร้างทางสังคมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การบริการสวัสดิการสังคม กิจกรรมชุมชน หน่วยงานของรัฐบาล และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการในสังคม กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการ และที่ไม่เป็นทางการ ทัศนคติและคตินิยม 2.4 ปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์หรือภูมิหลังของชีวิต และการดำรงชีวิต หรือสถานะสุขภาพ เพศ เชื้อชาติ อายุ ภาวะสุขภาพอื่น ๆ รูปแบบการดำเนินชีวิต อุปนิสัย การเลี้ยงดู รูปแบบการเผชิญและจัดการกับปัญหา พื้นฐานทางสังคม การศึกษา อาชีพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน พฤติกรรม บุคลิกภาพ จิตวิทยาบุคคล
4. วินิจฉัยปัญหา	4.1 วินิจฉัยปัญหาและระดับความรุนแรง ดังนี้ ระดับความรุนแรง ระดับความบกพร่อง หรือระดับความสามารถในการทำกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า "ตัวบ่งคุณลักษณะ" โดยบันทึกเป็นตัวเลขด้านหลังรหัส แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 0 หมายถึง ไม่มีความบกพร่องหรือความยากลำบากหรือไม่มีปัญหา (NO : 0–4 %) 1 หมายถึง มีความบกพร่องหรือความยากลำบากหรือมีปัญหาเล็กน้อย (MILD: 5 – 24 %) 2 หมายถึง มีความบกพร่องหรือความยากลำบากหรือมีปัญหาปานกลาง (MODERATE : 25 – 49 %) 3 หมายถึง มีความบกพร่องหรือความยากลำบากหรือมีปัญหารุนแรง (SEVERE : 50 – 95 %) 4 หมายถึง มีความบกพร่องหรือความยากลำบากหรือมีปัญหาที่รุนแรงหรือทั้งหมด (COMPLETE : 96–100 %) 8 Non Specified ในกรณีที่ระบุรายละเอียดของความบกพร่องหรือความยากลำบาก

ขั้นตอนการปฏิบัติ (ต่อ)

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม
4. วินิจฉัยปัญหา (ต่อ)	9 Not Applicable ในกรณีที่เห็นว่ากลุ่มรหัสนี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายนี้ (Not applicable) 4.2 ลงบันทึกตามแบบประเมิน
5. กำหนดแผนการจัดบริการ การรักษา บำบัดฟื้นฟู	5.1 จัดลำดับขั้นตอนการช่วยเหลือ รวมถึงการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็น ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านที่อยู่อาศัย 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านอาชีพและรายได้ 4) ด้านสาธารณสุข 5) ด้านความมั่นคงปลอดภัย 6) ด้านสันติภาพ 7) ด้านบริการสังคม 5.3 วางแผนและฟื้นฟูสมรรถภาพสังคม 5.4 จัดประชุม Case Conference เพื่อวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยรายกรณี 5.5 จัดทำแผนบริการทางสังคม (Social Care Plan): ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย (Stakeholders) เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5.6 ประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานบริการหรือองค์กรที่สามารถให้การดูแลต่อเนื่อง
6. ติดตามประเมินผล	6.1 โดยการสังเกต สอบถาม เยี่ยมบ้าน ติดตามทางแพทย์และสังคม 6.2 สรุปผลการช่วยเหลือ

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ใช้เวลาครั้งละ 30 นาที

อ้างอิง : INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH (ICF) 17
[HTTPS://WWW.WHO.INT/STANDARDS/CLASSIFICATIONS/INTERNATIONAL-CLASSIFICATION-OF-FUNCTIONING-DISABILITY-AND-HEALTH](https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health) สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2566

7. การจัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

คำนิยาม

การจัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ใช้กระบวนการและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์ชุมชน

- 1) จัดทำแผนกิจกรรมการดูแลรายบุคคล (SOCIAL CARE PLAN) ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
- 2) จัดโปรแกรมหรือกิจกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการให้บริการที่ส่งมาจากหน่วยบริการเพื่อพิจารณา
- 3) ประเมินวิเคราะห์เพื่อการให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับมิติทางสังคม

4) วางแผนกิจกรรมทางสังคมในการดูแลและพัฒนาทักษะชีวิต โดยพิจารณาการทำกิจกรรมจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวในผู้สูงอายุด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณสุขโรคและความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน

- 5) วางแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรมเชิงสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวรายบุคคลในครอบครัว โดยชุมชน ตามสภาพปัญหา

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม
1. เตรียมผู้ป่วยและญาติ	สร้างสัมพันธภาพ ทำความเข้าใจกับความคาดหวังของผู้ป่วย ญาติ และชุมชน
2. รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย	การสัมภาษณ์ทางวิชาชีพ เยี่ยมบ้านและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา ประเมิน และ วิเคราะห์ปัญหาทางสังคม	3.1 ประเมิน วิเคราะห์ความต้องการการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประเมินด้านกาย-จิต-สังคม (Bio-Psycho-Social Assessment) ความต้องการจำเป็นในการจัดบริการ (Need Assessment) ประเมินครอบครัว (Family Assessment) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประเมินทรัพยากร (Resource Assessment) ปัญหาและอุปสรรค 3.2 วิเคราะห์ปัญหาทางสังคมที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย และภาวะพึ่งพิงโดยเปรียบเทียบจัดลำดับความสำคัญ ความสัมพันธ์ความรุนแรงของปัญหา
4. วินิจฉัยปัญหา	4.1 สรุปปัญหาทางสังคมที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วย 4.2 ลงบันทึกตามแบบรายงานสังคมสงเคราะห์
5. กำหนดแนวทางการทำงาน	5.1 รายกลุ่ม, รายบุคคล, รายครอบครัว, ทรัพยากรที่ต้องใช้
6. จัดทำแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพ กาย จิต สังคม และฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	1) จัดทำแผนกิจกรรมการดูแลรายบุคคล (Social Care Plan) ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2) วางแผนกิจกรรมทางสังคมในการดูแลและพัฒนาทักษะชีวิต โดยพิจารณาการทำกิจกรรมจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวในผู้สูงอายุด้านสวัสดิการสังคม และสาธารณูปโภคและความเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน 3) จัดโปรแกรมหรือกิจกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการให้บริการที่ส่งมาจากหน่วยบริการเพื่อพิจารณา 4) วางแผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกิจกรรมเชิงสังคมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวรายบุคคลในครอบครัว โดยชุมชน ตามสภาพปัญหาการติดตามผลด้านการแพทย์และสังคม 5) ทำงานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพและผู้ใช้บริการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้ใช้บริการเผชิญ เช่น ข้อมูลจากครอบครัวสามี-ภรรยา เพื่อน เพื่อนบ้าน ตลอดจน คนในชุมชน เป็นต้น 6) วางแผนต้องเชื่อมโยงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสถานการณ์ เช่น ระบบคน ระบบงาน ระบบสภาพแวดล้อม เป็นต้น มาบูรณาการและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 7. ประสานงาน / ส่งต่อ
7. ติดตามประเมินผล	7.1 ติดตามความคืบหน้าของผู้ใช้บริการ 7.2 ประเมินผลและปรับแผนการดูแลตามความจำเป็น 7.3 สรุปผลการช่วยเหลือ

หมายเหตุ : 1. ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ใช้เวลาครั้งละ 60 นาที

8. การเยี่ยมบ้านโดยนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

คำนิยาม

การเยี่ยมบ้านโดยใช้กระบวนการสังคมสงเคราะห์ชุมชน จะมีการดำเนินการได้ใน 3 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่ม ระยะระหว่างการรักษา และระยะหลังจำหน่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ จำเป็นพร้อมกับการนำไปวางแผนการจัดบริการทางสังคมสงเคราะห์และประกอบการวางแผนการรักษา และการบำบัดฟื้นฟู

1. การเตรียมตัวก่อนการเยี่ยมบ้าน :

- การรวบรวมข้อมูล : ศึกษาประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้รับบริการเพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการเบื้องต้น
- การกำหนดวัตถุประสงค์ : วางแผนและกำหนดเป้าหมายของการเยี่ยมบ้านให้ชัดเจน
- การนัดหมาย : ติดต่อและนัดหมายกับผู้รับบริการหรือครอบครัวล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและความพร้อมของทั้งสองฝ่าย

2. ขั้นตอนระหว่างการเยี่ยมบ้าน :

- การสร้างสัมพันธภาพ : ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจกับผู้รับบริการ
- การประเมินสภาพแวดล้อม : สังเกตสภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้รับบริการ
- การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม : สอบถามและสังเกตเพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการช่วยเหลือ

3. หลังการเยี่ยมบ้าน :

- การบันทึกข้อมูล : จัดทำบันทึกสรุปเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน ข้อมูลที่ได้รับ และข้อสังเกตต่าง ๆ
 - การวางแผนการช่วยเหลือ : นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการช่วยเหลือที่เหมาะสม
 - การติดตามผล : กำหนดวิธีการและช่วงเวลาในการติดตามผลการช่วยเหลือ
- เทคนิคที่สำคัญในการเยี่ยมบ้าน :
- ทักษะการสื่อสาร : การฟังอย่างตั้งใจ การใช้ภาษาที่เหมาะสม และการตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
 - การสังเกต : สังเกตพฤติกรรม ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่
 - การปรับตัว : ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารหรือแนวทางการช่วยเหลือตามสถานการณ์ และวัฒนธรรมของผู้รับบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม	เวลา
1. เตรียมการ	1.1 สรุปรวข้อมูลในชุมชน 1.2 ศึกษาสภาพปัญหา และความจำเป็นจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกต 1.3 นัดหมาย แจ้งวัตถุประสงค์ 1.4 ศึกษาเส้นทางเดินทาง และสถานที่ 1.5 เตรียมอุปกรณ์ พาหนะ	
2. กำหนดปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย	2.1 กำหนดปัญหา การร่วมกับองค์กรในชุมชนพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ปัญหาใดควรจะได้รับ การ แก้ไขเร่งด่วน 2.2 วิเคราะห์ปัญหา การหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข	

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	อธิบายเพิ่มเติม	เวลา
3. จัดทำแผนงาน	3.1 วางแผนดำเนินงาน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย พิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการ 3.2 จัดทำแผนงานหรือ โครงการการประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3.3 นำผลการสำรวจข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของปัญหาและตามนโยบายของหน่วยงาน 3.4 กำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ระยะเวลา งบประมาณ การประเมิน ผลที่คาดว่าจะได้รับ	
4. ดำเนินการ	4.1 การเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ ● ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น คนพิการ เด็กและสตรีที่ถูกรังแกทำรุนแรง ผู้ติดเชื่อเฮดส์ ฯลฯ ● ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร และบรรยายให้ความรู้ 4.2. การประสานงานกับชุมชน ● ติดต่อองค์กรและผู้นำชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือ ● จัดประชุม สัมมนา อบรม และให้คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ 4.3. การให้บริการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ● ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ผู้มีปัญหาสังคม ● ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ ● สนับสนุนด้านเศรษฐกิจ เช่น นมผง อาหารเสริม ● ติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.4. การเฝ้าระวังและฟื้นฟูสังคม ● เฝ้าระวังปัญหาสังคมในชุมชน ● ฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ ● สร้างเครือข่ายบริการทางสังคมผ่านการประชุมและอบรม	180 นาที
5. ประเมินและติดตามผล	5.1 ติดตามประเมินผล การสรุปผลการดำเนินงาน การประชุมร่วมกันระหว่างทีมงานเพื่อให้ ทราบถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงาน นำเป็นข้อมูลมาใช้ในการวางแผนงานครั้งต่อไป โดย วิธีการ สอดถาม สัมภาษณ์ ประชุม สังเกต ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน จากสถิติ รายงาน ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์	

9.

การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิต และติดตามประเมินปัญหาทางสังคม ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ และการฟื้นฟูสภาพ (RECOVERY) ผู้ป่วยหลังจำหน่าย

คำนิยาม

การติดตามผลประเมินคุณภาพชีวิตและติดตามประเมินปัญหาทางสังคม ป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ และการฟื้นฟูสภาพ (RECOVERY) ผู้ป่วยหลังจำหน่าย นักสังคมสงเคราะห์ ใช้กระบวนการและวิธีการทางสังคม สงเคราะห์ติดตามผลและประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังจำหน่าย ในครอบครัว /โรงเรียน /ชุมชน /วัด และ สถานประกอบการโดยใช้โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสังคม ให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำหน้าที่ทางสังคมได้

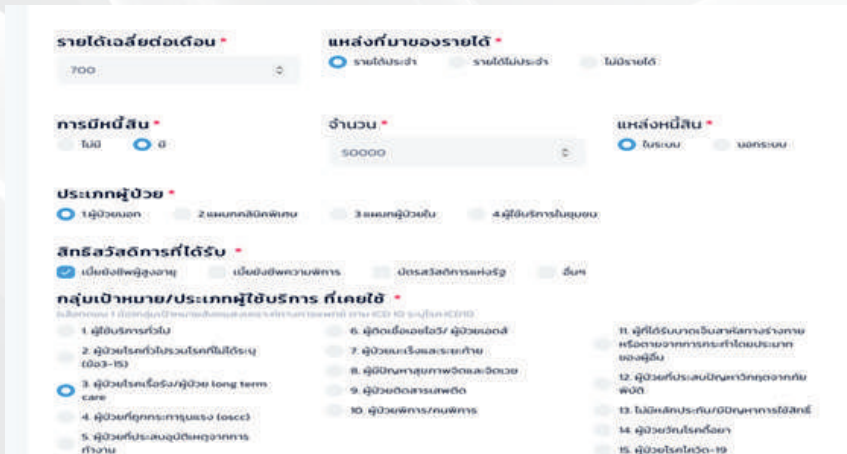
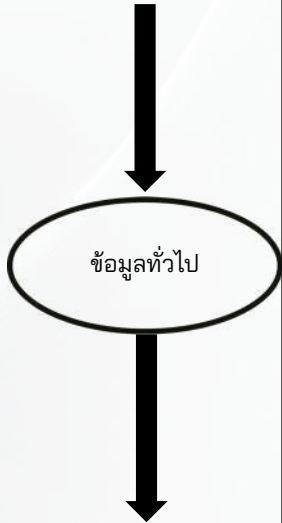
คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ของบุคคลภายใต้บริบททางวัฒนธรรมและคุณค่าที่คนผู้นั้นอาศัย อยู่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายความคาดหวังมาตรฐานและสิ่งที่เกี่ยวข้องของบุคคลผู้นั้น เป็นมโนทัศน์หลายมิติ ที่ประสานการรับรู้ของบุคคลใน ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสภาวะจิตใจ ระดับความเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพา ด้านความ สัมพันธ์ทางสังคม ด้านความเชื่อส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (WORLD HEALTH ORGANIZATION : 1997)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

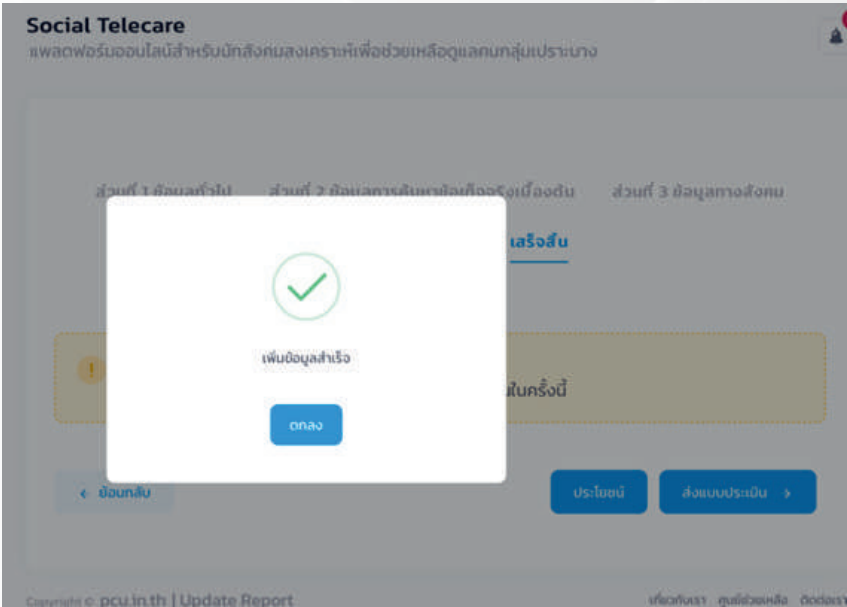
ลำดับ	ขั้นตอน	รายละเอียด
1	การติดตามผลและประเมินคุณภาพชีวิต	- สัมภาษณ์ผู้ป่วยและครอบครัว - ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต - ประเมินสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน
2	การติดตามและประเมินปัญหาทางสังคม	- ประเมินปัญหาด้านที่อยู่อาศัย การเงิน ความสัมพันธ์ - ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
3	การป้องกันการเจ็บป่วยซ้ำ	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค - ติดตามการปฏิบัติตามแผนการรักษา - ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
4	การฟื้นฟูสภาพ (Recovery)	- วางแผนการฟื้นฟู - ให้การสนับสนุนทางจิตสังคม - เชื่อมโยงกับทรัพยากรชุมชน

หมายเหตุ : เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 60 นาที

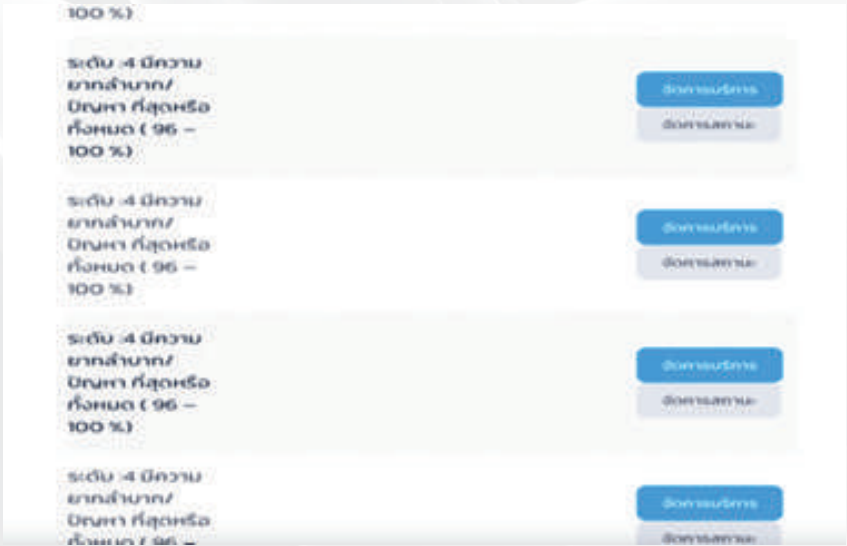
ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม ใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

บันทึกข้อมูลผู้ป่วย	Step 1
ขั้นแรกท่านต้องระบุข้อมูลทั่วไปให้เสร็จสิ้นในส่วนของ *ไม่สามารถเว้นว่างได้ ให้ท่านใส่ข้อมูลที่จำเป็นอาทิ รายได้ สวัสดิการ ประเภทผู้ป่วย จำนวนหนี้สิน เป็นต้น  เมื่อระบุข้อมูลทั่วไปเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินเครื่องมือโดยระบบจะบังคับให้ประเมินเครื่องมือวินิจฉัยและปัญหาทางสังคม	ข้อมูลทั่วไป 

ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม ใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

ประเมินประเด็นปัญหา	Step 2
ข้อที่ 12 ปัญหาการศึกษา (d820) * นิยาม ☐ ไม่มีความยากลำบาก/ปัญหา (0 – 4 %) ☐ มีความยากลำบาก /ปัญหา เล็กน้อย (: 5 – 24 %) ☐ มีความยากลำบาก /ปัญหา ปานกลาง (25 – 49 %) ☒ มีความยากลำบาก/ปัญหา รุนแรง (50 – 95 %) ☐ มีความยากลำบาก/ปัญหา ที่สุดหรือทั้งหมด (96 – 100 %) ☐ ไม่ระบุ ☐ ไม่เกี่ยวข้อง ข้อที่ 13 ปัญหาการประกอบอาชีพ (d845) * นิยาม ☐ ไม่มีความยากลำบาก/ปัญหา (0 – 4 %) ☐ มีความยากลำบาก /ปัญหา เล็กน้อย (: 5 – 24 %) ☐ มีความยากลำบาก /ปัญหา ปานกลาง (25 – 49 %) ☐ มีความยากลำบาก/ปัญหา รุนแรง (50 – 95 %) ☒ มีความยากลำบาก/ปัญหา ที่สุดหรือทั้งหมด (96 – 100 %) ☐ ไม่ระบุ ประเมินประเด็นปัญหา	 เครื่องมือประเมิน 
 เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จให้ท่านกดตกลง	

ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม ใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

เพิ่มกิจกรรมบริการ	Step 3
ท่านสามารถเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา เพิ่มกิจกรรมบริการสังคมสงเคราะห์ ปัญหา: ปัญหาการเงิน ระดับปัญหา: 3 ประเภท * ☐ ประเภทการประเมินตัวใจจิต ☒ ประเภทการให้คำปรึกษาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ☐ ประเภทการบำบัดรักษา ☐ ประเภทการฟื้นฟูทางการแพทย์และสังคม ☐ ประเภทการดูแลเสริมฟื้นฟู ☒ ประเภทติดตามผลด้านการแพทย์และสังคม เมื่อเลือกกิจกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้โดยอัตโนมัติ ราคารวม * 1750 เมื่อคลิกที่ปุ่มรายงานผลการบำบัดข้างต้นระบบจะนำท่านไปสู่รายงานผลการบำบัดท่านสามารถนำรายงานผลการบำบัดไปใช้งานต่อไปได้	↓ ออกแบบแผนและจัด บริการทางสังคม ↓
จัดการสถานะ	
 ท่านสามารถเข้ามาอัปเดตสถานการณ์จัดบริการได้ในขั้นตอนของการออกแบบและจัดบริการทางสังคม โดยหากสถานะเป็นจัดบริการเสร็จสิ้นระบบจะขึ้นในหน้ารายการบันทึกข้อมูล	↓

ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลทางสังคม ใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

รายงานผล

คลิกรายงานผลการบำบัด

Step 4

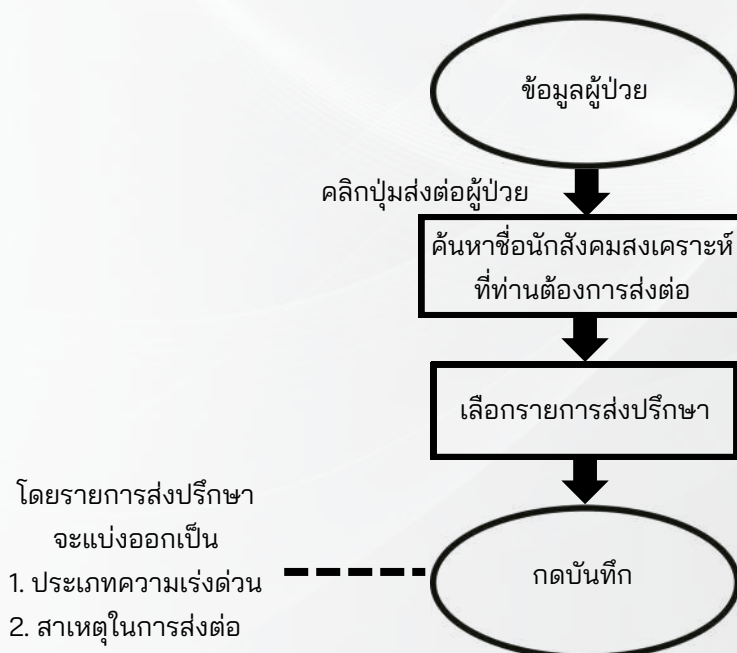
↓

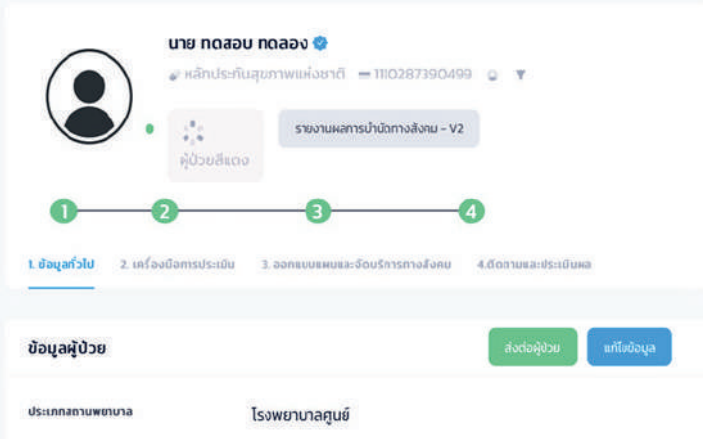
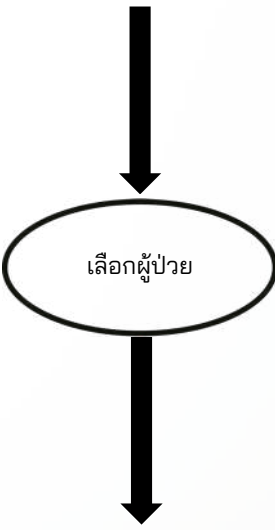
รายงานผลการบำบัด

10. การประสานงานและส่งต่อ (COORDINATION & REFERRAL)

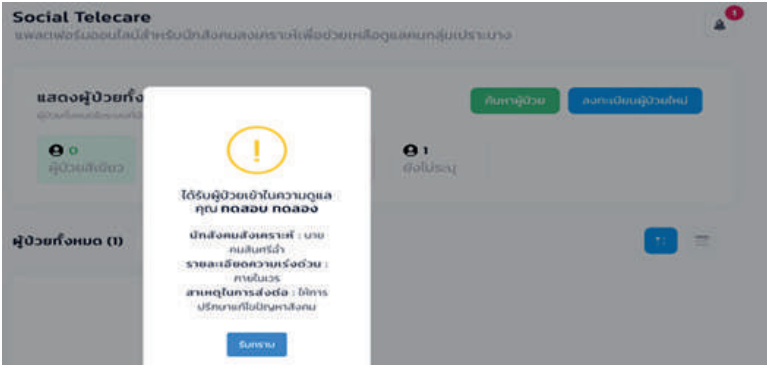
เชื่อมโยงข้อมูลและบริการระหว่างบุคลากรสหสาขาวิชาชีพและหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบส่งต่ออัตโนมัติใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

PROCESS ขั้นตอนของผู้ส่งปรึกษา



เลือกผู้ป่วย	Step 1
ขั้นแรกให้ท่านเข้ามาเลือกผู้ป่วยที่ท่านต้องการส่งปรึกษา โดยสามารถเข้ามาที่หน้าผู้ป่วยในความดูแลคลินิกปุ่มรายละเอียดของผู้ป่วยดังกล่าว  ระบบจะนำท่านมาสู่หน้าข้อมูลทวไปเหทานคลกปุมสงตอผู้ป่วย 	
ค้นหารายชื่อ	Step 2
ให้ท่านค้นหาชื่อนักสังคมสงเคราะห์ที่ท่านต้องการส่งต่อ  เมื่อท่านเลือกรายชื่อเรียบร้อยแล้วระบบจะนำท่านสู่การเลือกรายการส่งปรึกษา แบ่งออกเป็นรายละเอียดความเร่งด่วนและสาเหตุในการส่งต่อ คลิกบันทึกระบบจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังปลายทาง	

ขั้นตอนของผู้รับปรึกษา

แจ้งเตือนการรับปรึกษา	Step 1
เมื่อนักสังคมสงเคราะห์ผู้ส่งปรึกษาส่งปรึกษาเคสแล้ว ระบบจะทำการขึ้นหน้าต่างการยินยอมรับการปรึกษาแก่ผู้รับปรึกษา  กรณีที่ท่านไม่พบหน้าต่างท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการแจ้งเตือนตรงสัญลักษณ์กระดิ่งมุมบนขวาได้	↓ ระบบแจ้งเตือนการรับปรึกษาเคสจากต้นทาง ↓
ประวัติรายการการส่งปรึกษาและการรับปรึกษา	Step 2
ข้อมูลการส่งต่อจะถูกบันทึกอยู่ในหน้าต่างการติดตามและประเมินผลของผู้ป่วยรายนั้น 	↓ ระบบจะมีการเก็บข้อมูลการรับและส่งปรึกษาเคสในหน้าต่างการติดตามและประเมินผลของผู้ป่วยรายนั้น

ข้อสรุป

งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์มีความสำคัญในระบบบริการสุขภาพสมัยใหม่ เนื่องจากไม่เพียงแต่ดูแลผู้ป่วย ในด้านร่างกายและจิตใจ แต่ยังเน้นที่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม SOCIAL TELECARE ยังช่วยให้การให้บริการเข้าถึงผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นและลดข้อจำกัดด้านระยะทางและเวลา การทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพที่ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ “PERSON IN ENVIRONMENT” ในการวิเคราะห์และออกแบบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้การถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรมยังช่วยให้บุคลากรในสาขาสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญและรักษามาตรฐานของวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง การทำงานของนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลมีความเป็นระบบมากขึ้น โดยยึดหลักฐานเชิงประจักษ์ (EVIDENCE-BASED PRACTICE) ผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะทาง ตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ควบคู่กับศิลปะแห่งความเข้าใจมนุษย์ เช่น การสื่อสารเชิงสัมพันธ์ และการเข้าถึงบริบทชีวิตผู้ป่วยอย่างลึกซึ้ง การประสานระหว่างศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดภาระงานซ้ำซ้อน เร่งรัดการวางแผนดูแลรายบุคคล และลดข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือ

การให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์มีความสำคัญ เนื่องจากมีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวในหลายมิติ ทั้งทางด้านจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ บริการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพได้ดีขึ้น แต่ยังช่วยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปความสำคัญของการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์มีดังนี้

จุดแข็งของการใช้แพลตฟอร์ม SOCIAL TELECARE ในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

1. เข้าถึงได้ง่าย
 - ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถประเมินตนเอง(ในแบบตนเองขั้นประเมินพื้นฐาน)ได้ สหวิชาชีพสามารถให้บริการตามแผนการรักษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับตติยภูมิถึงระดับปฐมภูมิได้
2. ลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
 - ไม่ต้องรอคิวในโรงพยาบาล ลดภาระของเจ้าหน้าที่
3. สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 - ระบบออนไลน์ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับบริการได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน
4. มีระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์
 - ช่วยให้สังคมสงเคราะห์สามารถติดตามพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของผู้ป่วยได้ผ่านระบบดิจิทัล

ด้านข้อจำกัดและความท้าทาย

แม้จะมีบทบาทสำคัญ แต่บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น

1. ทรัพยากรบุคคล
 - จำนวนนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
 - ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมยังไม่กระจายตัวและแพร่หลาย
2. เทคโนโลยีและการสื่อสาร
 - การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการยังไม่แพร่หลายในบางพื้นที่ทำให้การเข้าถึงบริการเป็นไปได้

“

อนาคตของงานสังคมสงเคราะห์
ไม่ได้อยู่ที่การเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
แต่อยู่ที่การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

THE FUTURE OF SOCIAL WORK IS NOT ABOUT CHOOSING
THE BEST TECHNOLOGY, BUT ABOUT USING TECHNOLOGY
TO BRING THE GREATEST IMPACT TO THOSE IN NEED

”

ภาคผนวก

ตารางแสดงการใช้เครื่องมือออนไลน์ ใน PLATFORM SOCIAL TELECARE

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
1) เครื่องมือประเมิน วินิจฉัยและจัดการทางสังคม (Social Diagnosis and Management Assessment) S.D.M.A.	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกราย	สภามหาวิทยาลัยสังคมสงเคราะห์และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย	0.81 - 0.96	0.876
2) เครื่องมือประเมินความพร้อมของครอบครัว (Family Readiness Assessment :F.R.A.)	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรง	ผู้พัฒนาเครื่องมือ ดร.สดี คุ่มทรัพย์อนันต์ และคณะ, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	0.8 - 1.00	0.908
3) เครื่องมือแบบประเมินทักษะพื้นฐานในการทำงานและทักษะการปรับตัวทางสังคม (Social skill Assessment : S.S.A.)	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1. คนพิการ (7) 2. ผู้ป่วยจิตเวช(4)	ผู้พัฒนาเครื่องมือ ดร.สดี คุ่มทรัพย์อนันต์ และคณะ, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	ผ่านการตรวจแก้ไขจากที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพจิต และจิตเวช จำนวน 5 ท่าน	0.81
4) เครื่องมือประเมินการดูแลสุขภาพจิตตนเอง (Mental Self Care Assessment: M.S.C.A.)	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	1. คนพิการ (7) 2. ผู้ป่วยจิตเวช(4)	ผู้พัฒนาเครื่องมือ ดร.สดี คุ่มทรัพย์อนันต์ และคณะ, สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต	ไม่มี	0.896
5) เครื่องมือประเมินปัญหาทางสังคม ผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่/โรคติดต่อร้ายแรง	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ผู้ป่วย Post Covid (1)	ผู้พัฒนา นางเยาวเรศ คำมะนา และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย	CVI เท่ากับ 0.57 IOC ระหว่าง 0.73-0.97	0.83
6) ประเมินตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการเจ็บป่วย	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกราย	ผู้พัฒนา นางเยาวเรศ คำมะนา และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย	CVI เท่ากับ 0.57 IOC ระหว่าง 0.73-0.97	0.87
7) แบบฟอร์มการส่งต่อข้อมูลทางสังคม	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรงที่ต้องการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย	1	0.6

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
8) แบบติดตามและประเมินทางสังคม (Social Monitoring and evaluation) กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดสำหรับนักสังคมสงเคราะห์	นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด	รวบรวมโดยนางเยาวเรศ คำมะนาด สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย	0.978	0.757 อ้างอิง MATE: Measurement s in the Addictions for Triage and Evaluation http://www.mateinfo.eu
9) แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย (2-Q9Q8Q)	ทีมสหวิชาชีพ	1.ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/รุนแรง 2. ผู้ที่มาด้วยอาการซึมเศร้าชัดเจน 3. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ 4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ข้อเสื่อม ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ตีบตัน 5. ผู้ป่วยสูงอายุ 6. หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 7. ผู้ที่มีปัญหายาเสพติด 8. ผู้ที่ประสบกับการสูญเสียที่รุนแรงมาไม่นาน	กรมสุขภาพจิต	1) แบบ 2Q=0.68-0.76 2) แบบ 9Q=0.76-0.86 3) แบบ 8Q=0.70-0.81	
10) การทำผังครอบครัว การทำแผนที่สังคมมิติ และ Life Time	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกราย	Monica McGoldrick and Randy Gerson ซึ่งได้แต่งหนังสือเรื่อง Genograms: Assessment and Intervention	0.52-1.00	0.646

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
11) แบบสรุปประชุม ทีมสหวิชาชีพ (conference case)	ทีมสห วิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วย ทุกรายมี ปัญหาซับซ้อน/ รุนแรง	กองบริหารการ สาธารณสุข กระทรวง สาธารณสุข	0.74 – 1.00	0.896
12). แบบประเมินสมรรถ นะคนพิการ (International Classification of Functioning Disability and Health: ICF)	ทีมสห วิชาชีพ	1. คนพิการ (7)	อ้างอิง จากองค์การ อนามัยโลก (WHO) โดย สำนักนโยบายและยุทธ ศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวง กระทรวง สาธารณสุข	มี (WHO)	มี (WHO)
13) แบบประเมิน กิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL	ทีมสห วิชาชีพ	ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วย โรคหลอดเลือด สมอง : Stroke :Trauma brain injury : Spinal cord injury: Fracture around the hip	กรมอนามัย	0.8-1.0	0.46
14).แบบประเมินระดับ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแล แบบประคับประคอง ฉบับสวนดอก (Palliative performance Score: PPS Score) holistic care model	ทีมสห วิชาชีพ	ผู้ป่วยที่เป็น โรคที่รักษา ไม่ได้หรือ รักษาไม่หาย ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยระยะ ท้าย ผู้ป่วยเรื้อรัง ที่โรคดำเนิน มาจนถึง ระยะท้าย ผู้ป่วยที่มี เวลาเหลือไม่ นาน ผู้ป่วยโรค ชรา (ร่างกาย เสื่อมถอย): ผู้ป่วย Stroke เส้นเลือดใน สมองแตก หรือเกิด อุบัติเหตุและ สมองตาย	กลุ่มการพยาบาลโร งพยาบาลมหาชนคร เชียงใหม่ อ้างอิง จาก แบบประเมิน Palliative performance scale version 2 จากO Victoria Hospice ประเทศแคนาดา	-	ผ่านการทดสอบ ความเชื่อมั่น ด้วยวิธีสอบซ้ำ (Test – retest Method) และ ทดสอบโดยใช้ Two -ways random- effect models ได้ค่าความเชื่อ มั่นเท่ากับ 0.911 และ 0.92

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
15) แบบ ST5 แบบประเมินความเครียด	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/ รุนแรง	กรมสุขภาพจิต	0.667–1.000	0.86
16) แบบ ประเมินปัญหาการตีตรา (AUDIT)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปี ขึ้นไป	แผนงานการพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส) แปลภาษาไทยอ้างอิง มาจาก องค์การอนามัยโลก	0.8	0.95
17) แบบ Advance care plan การวางแผนล่วงหน้า ของผู้ป่วยระยะท้าย	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยระยะท้าย	กรมการแพทย์	0.92	0.9
18) เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI)	ทีมสหวิชาชีพ	ใช้กับผู้ป่วยทุกรายที่มีปัญหาซับซ้อน/ รุนแรง	ผู้พัฒนานายแพทย์สุวัฒน์ มหัตถ์รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	0.8-1.0	0.94
19) แบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ (Child maltreatment surveillance tool : CMST)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยเด็ก/ ผู้ป่วยเด็กและถูกกระทำรุนแรงทุกราย	พญ.ปรีชวัน จันทศิริ โรงพยาบาลพาลงกรณ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	มี ผ่านการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย	มี ผ่านการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
20) แบบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่เข้ารับบริการศูนย์พึ่งได้	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงทุกราย	กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	0.85 - 0.96	0.71
21) แบบคัดกรองความรุนแรงในครอบครัว Woman Abuse Screening Tool (WAST) version ภาษาไทย	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง	Associate Professor Dr. Tina Bloom จาก University of Missouri ดร. ทิพย์รัตน์ อุดมเมืองเพีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีเขื่อนแก่น	มี	0.73
22) แบบบันทึกการลงข้อมูลผู้ที่ตั้งครรถ์ไม่พึงประสงค์ที่เข้ารับบริการศูนย์พึ่งได้	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยตั้งครรถ์ไม่พร้อมทุกราย	กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	0.93 – 1.00	0.5

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
23) แบบคัดกรองความรุนแรงในครอบครัว	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยสตรีที่ถูกระทำรุนแรง	Associate Professor Dr. Tina Bloom จาก University of Missouri ดร. ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนอนแก่น	มี	0.85
24) แบบคัดกรองตามการวินิจฉัย DSM -5 ในผู้ป่วยยาและ สารเสพติด	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยใช้ยาและสารเสพติด	สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช)	61.9-72.7	0.79
25) แบบประเมินอาการทางจิต (BPRS)	พยาบาลวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	กรมสุขภาพจิต		อ้างอิง มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures: SOPs การบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW) กรมสุขภาพจิต , 2566
26) แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (OAS)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	กรมสุขภาพจิต		อ้างอิง มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures: SOPs การบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW) กรมสุขภาพจิต , 2566
27) แบบประเมินสุขภาพทางจิตของผู้ป่วยจิตเวช (HoNOS)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	กรมสุขภาพจิต		อ้างอิง มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures: SOPs การบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW) กรมสุขภาพจิต , 2566

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
28) แบบประเมินความรุนแรงอาการทางจิต (CGI-S)	จิตแพทย์	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	แปลเป็นภาษาไทย โดย วรวัฒน์ ไชยชาญ และคณะ (2561)		เครื่องมือวัดที่ พัฒนาขึ้นโดย National Institute of Mental Health (Psychopharmac ology Research Branch)
29) แบบประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยจิต เภท(F20-F29) (PANSS)	พยาบาล	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	กรมสุขภาพจิต		อ้างอิง มาตรฐาน การปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures: SOPs การบริการ ผู้ป่วยในจิตเวชและ ยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW) กรมสุขภาพจิต , 2566
30) แบบประเมินการ ความรุนแรงของ ความผิดปกติที่เกิดขึ้น กับผู้ป่วย (TMRS)	ทีม สหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	มีค่า item coefficient > 0.6 interrater Pearson's correlation =0.87,	Cronbach's alpha coefficient = 0.89
31) แบบประเมินส่วน ประกอบทางอารมณ์ (MOSAIC)	ทีมสห วิชาชีพ	ผู้ป่วยโรคซึม เศร้า Major depressive disorder, s ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ คณะ แพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	ค่าความถูกต้อง ในเนื้อหา อยู่ในระดับ 0.6-1.0 ความ สอดคล้อง ภายใน (internal consistencie s) ของแบบวัด มีค่า standardized	ค่า Cronbach's alpha coefficient=0.80 48
32) แบบวัดภาระใน การดูแลผู้ป่วยจิต เภท/ญาติ (Burden of care)	ทีมสห วิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	พ.ญ อรพรรณ ศิลปกิจ โรงพยาบาล ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	ค่าความ สัมพันธ์ ระหว่างข้อ คำถาม ระหว่าง 0.75 – 0.95 แบบ ประเมินมี ความ สอดคล้อง ภายในทั้งฉบับ 0.88	-

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
33) แบบประเมินระดับความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา (CIWA-Ar)	พยาบาล / จิตแพทย์	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	นพ.ภาณุ คูณฉายกร และวารุณี รัศมีสุวรรณ (2564) รพ.สวนปรุง	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระดับ 0.01 ($r=0.999^{**}$)	ค่าความเชื่อมั่นรายข้อในระดับ ตั้งแต่ 0.17-0.94
34) แบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา (AWS)	พยาบาล / จิตแพทย์	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	นายแพทย์อังกร ภัทรากกร และคณะ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2558		อ้างอิง แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุรา
35) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of change)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยยาเสพติด	ดร.ณี ภูขาว และคณะ, 2549) หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล		อ้างอิงจาก คู่มือบำบัดสุราประเภท PMK-CBI ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 1991 แปลและตรวจสอบคุณภาพโดย(The Contemplation Ladder, Biener and Adams,
36) แบบประเมินอาการเตือนการกำเริบซ้ำของโรคติดสุรา (AWARE -Thai)	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	แปลเป็นภาษาไทยโดยภาณุ คูณฉายกร และจารุณี รัศมีสุวรรณ (2564) รพ.สวนปรุง		พัฒนามาจากแบบประเมินสัญญาณเตือนการกลับไปดื่มสุราซ้ำสร้างขึ้นตามแนวคิด Post-Acute Withdrawal Syndrome (PAWS) (Miller & Harris, 2000)
37) แบบติดตามผู้ป่วยจิตเวช เรื้อรังในชุมชน 10 ด้าน	ทีมสหวิชาชีพ	ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด	กรมสุขภาพจิต		อ้างอิง มาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures: SOPs การบริการผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้าน (Psychiatric Home Ward: PHW) กรมสุขภาพจิต ,2566

เครื่องมือ	ผู้ใช้เครื่องมือ	การใช้เครื่องมือ	อ้างอิง	ค่า IOC	ค่าความเที่ยง/ ค่าความเชื่อมั่น
38) แบบประเมิน ความเสี่ยงทาง คลินิก(SAVE)	ทีมสห วิชาชีพ	ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช	นายแพทย์ณัฐไกร ภัสสรพงษ์ นางธัญ ลักษณ์แก้วเมือง กรม สุขภาพจิต , 2564		อ้างอิง จาก เอกสาร เวช ระเบียนผู้ป่วย จิตเวช สำหรับ สถาบัน/ โรง พยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพ จิต (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

เอกสารอ้างอิง

1. PDSA ในโรงพยาบาล. นนทบุรี: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน).
2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). (2563). คู่มือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ฉบับโรงพยาบาลชุมชน. นนทบุรี: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน).
3. WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2019). INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES AND RELATED HEALTH PROBLEMS: 10TH REVISION (ICD-10) (5TH ED.). GENEVA, SWITZERLAND: AUTHOR. [HTTPS://WWW.WHO.INT/PUBLICATIONS/I/ITEM/9789241549165](https://www.who.int/publications/i/item/9789241549165)
4. WORLD HEALTH ORGANIZATION. (1997). MEASURING QUALITY OF LIFE: THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) INSTRUMENTS. GENEVA, SWITZERLAND: AUTHOR.
5. WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2011). ICF: A GUIDE TO THE USE OF THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH. GENEVA, SWITZERLAND: AUTHOR.
6. NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. (2004). STANDARDS FOR SOCIAL WORK PRACTICE IN HEALTH CARE SETTINGS. WASHINGTON, DC: NASW PRESS.
7. NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS. (2005). STANDARDS FOR CLINICAL SOCIAL WORK IN SOCIAL WORK PRACTICE. WASHINGTON, DC: AUTHOR.
8. MCGOLDRICK, M., & GERSON, R. (1985). GENOGRAMS: ASSESSMENT AND INTERVENTION. NEW YORK, NY: W. W. NORTON & COMPANY.
9. WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2023). INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES FOR MORTALITY AND MORBIDITY STATISTICS (11TH ED.). [HTTPS://ICD.WHO.INT](https://icd.who.int)
10. WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2022). GLOBAL TUBERCULOSIS REPORT 2022. [HTTPS://WWW.WHO.INT/PUBLICATIONS/I/ITEM/9789240061729](https://www.who.int/publications/i/item/9789240061729)
11. DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL, THAILAND. (2022). NATIONAL STRATEGIC PLAN TO END TB (2021–2026). MINISTRY OF PUBLIC HEALTH.
12. PUNGRASSAMI, P., KHAMDUANG, W., & AKARASEWI, P. (2010). FACTORS AFFECTING NON - ADHERENCE TO TUBERCULOSIS TREATMENT IN THAILAND: A SYSTEMATIC REVIEW. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND, 93(6), 709–716.
13. กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข. (2562). คู่มือฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเพื่อการมีงานทำของผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักสังคมสงเคราะห์. กรุงเทพฯ: ไม่ระบุสำนักพิมพ์.
14. สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย. (2563). แนวทางการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์. กรุงเทพฯ: ไม่ระบุสำนักพิมพ์.
15. ระพีพรรณ คำหอม และคณะ. (2565). รายงานโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).
16. สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย. (2560). แนวทางการวินิจฉัยและจัดการทางสังคม (SOCIAL PROBLEM LIST) ที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับรหัส ICF ของ WHO. กรุงเทพฯ: สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย.
17. คณะอนุกรรมการการปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข (นักสังคมสงเคราะห์). (2568). รายการบริการสังคมสงเคราะห์ 5 ระบบ 40 บริการใน PLATFORM SOCIAL TELECARE. กรุงเทพฯ: สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์.
18. ศราวุธ หรีกประโคน และคณะ. (2568). มาตรฐานการปฏิบัติงานการบริการผู้ป่วยคลินิกสังคมสงเคราะห์ (STANDARD OPERATING PROCEDURES OF SOCIAL WORK CLINIC). กรุงเทพฯ: สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์. (พิมพ์ที่ ร้านพิมพ์สวयरการพิมพ์, 2024). ISBN: 978-616-94737-2-5



เจ้าของลิขสิทธิ์
สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
เลขที่ 255 ตึกกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แขวงจันทน์พนาภิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2050 9427, 09 8380 1351 (สำนักงาน)
e-mail: thaisocialworkcouncil@gmail.com